



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN
PASIEN
TAHUN 2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 1068.1/I-PDM/DIR/VIII/2024

Tentang
Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM PAP



(dr. Sheila Dyah Prasetyo)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2024 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 12 Agustus 2024
PLT Direktur RS Prima Husada

dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi
3. dr. Sheila Dyah Prasetyo
4. Ns. Risma Indra Setiyani, S. Kep
5. Ns. Very Susanto, S. Kep
6. Veni Lestari Putri Purnami, AMd. Gz

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARII

TIM PENYUSUNIII

DAFTAR ISI IV

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA V

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1

 1.3 SASARAN..... 2

 1.4 RUANG LINGKUP 2

 1.5 PENGERTIAN..... 2

BAB II SKRINING.....4

 2.1 SKRINNING 5

 2.2 SKRINNING PASIEN DENGAN KETERBATASAN FISIK..... 7

 2.3 SKRINNING WILAYAH 7

BAB III TRIAGE.....8

BAB IV ASUHAN PASIEN.....13

BAB V RENCANA ASUHAN15

 5.1 PENGKAJIAN AWAL 15

 5.2 RENCANA ASUHAN..... 16

BAB VI PENGKAJIAN ULANG18

BAB VII PPA19

BAB VIII HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN ASUHAN21

 8.1 HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN 21

 8.2 IDENTIFIKASI AGAMA,KEYAKINAN DAN NILAI-NILAI PRIBADI 22

 8.3 HAK PRIVASI PASIEN..... 22

 8.4 PENYIMPANAN BARANG MILIK PASIEN 23

 8.5 IDENTIFIKASI POPULASI DENGAN RESIKO KEKERASAN 23

 8.6 SECOND OPINION..... 24

 8.7 PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN 24

 8.8 HAK MENOLAK ATAU TIDAK MELANJUTKAN PENGOBATAN..... 25

 8.9 HAK MENOLAK RESUSITASI 25

BAB IX ALUR PASIEN26

BAB X PENUNDAAN PELAYANAN28

BAB XI KESINAMBUNGAN PASIEN29

BAB XII PEMULANGAN PASIEN (DISCHARGE PLANNING)31

 12.1 PEMULANGAN PASIEN 31

 12.2 PENANGAN PASIEN MELARIKAN DIRI 33

BAB XIII KRITERIA PASIEN RAWAT JALAN KOMPLEKS34

BAB XIV PENOLAKAN ASUHAN MEDIS.....35

BAB XV TRANSFER INTRAHOSPITAL36

BAB XVI RUJUKAN38

BAB XVII PENUTUP43



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR: 1068.2/I-KEP/DIR/VIII/2024

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa pelayanan dan asuhan kepada pasien rumah sakit merupakan hal pokok dalam pelayanan rumah sakit;
- b. bahwa dalam pemberian pelayanan dan asuhan pasien memerlukan acuan agar dapat dilaksanakan secara seragam, konsistensi dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan KEmatian dan Pemanfaatan Organ Donor;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine;
14. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001.204/DPM/I-KEP/DIR/I/2024 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima HUsada;
15. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/V/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 2) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
- 3) Staf klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung pada pasien
- 4) Profesional Pemberi Asuhan adalah staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien.
- 5) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya.
- 6) Perawat Penanggung Jawab Asuhan adalah perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya.
- 7) Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
- 8) Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.
- 9) Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik.
- 10) Telemedicine adalah pemberian pelayanan Kesehatan jarak jauh oleh professional Kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan Pendidikan berkelanjutan penyedia layanan Kesehatan untuk kepentingan peningkatan Kesehatan individu dan masyarakat.
- 11) Homecare merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan pada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan Kesehatan atau



memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit. Layanan homecare dilakukan oleh perawat untuk melakukan tindakan tertentu sesuai kompetensi perawat.

- 12) Homevisit adalah kunjungan ke tempat tinggal pasien yang dilakukan oleh dokter umum dan perawat untuk melakukan pemeriksaan dasar dan tatalaksana sesuai kompetensi dokter umum.

BAB II

SKRINING

Pasal 2

- 1) Skrining dilakukan untuk menilai apakah rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan pasien serta konsisten dengan misi rumah sakit;
- 2) Skrining dilaksanakan melalui kriteria triage, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisik, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging.
- 3) Pada pelaksanaan skrining, dapat ditentukan tes atau bentuk penyaringan terhadap populasi pasien tertentu sebelum menetapkan pasien dapat dilayani.
- 4) Pasien diterima bila rumah sakit dapat memberi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dibutuhkan pasien.
- 5) Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien.

BAB III

TRIAGE

Pasal 3

- 1) Kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat meliputi triage; dan tindakan penyelamatan nyawa (life saving).
- 2) Pada setiap pasien yang datang ke instalasi gawat darurat harus dilakukan triage.
- 3) Triage merupakan pemeriksaan awal atau skrining secara cepat terhadap semua pasien yang datang ke instalasi gawat darurat untuk mengidentifikasi status kegawat daruratannya dan prioritas penanganan.

BAB IV

ASUHAN PASIEN

Pasal 4

- 1) Asuhan pasien dilakukan oleh PPA dan staf klinis yang kompeten dan berwenang.
- 2) Asuhan pasien dapat berupa upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau rehabilitatif termasuk anestesia, tindakan bedah, pengobatan, terapi suportif, atau kombinasinya, yang berdasarkan hasil pengkajian dan pengkajian ulang pasien.



- 3) Pelaksanaan asuhan dan pelayanan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh semua PPA, dan dapat dibantu oleh staf klinis lainnya.
- 4) Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat asuhan yang sama/seragam di rumah sakit.
- 5) Asuhan pasien yang seragam terefleksi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan tidak bergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembayaran.
 - b. Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan yang diberikan oleh PPA yang kompeten tidak tergantung pada hari atau jam yaitu 7 (tujuh) hari, 24 (dua puluh empat) jam
 - c. Kondisi pasien menentukan sumber daya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhannya
 - d. Pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, sama di semua unit pelayanan di RS misalnya pelayanan anastesi
 - e. Pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan yang sama akan menerima tingkat asuhan keperawatan yang sama di semua unit pelayanan di RS

Pasal 5

- 1) Pelayanan dan asuhan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk pelayanan dan asuhan pasien terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal.
- 2) Pelayanan/asuhan terintegrasi horizontal melibatkan kontribusi PPA yang sama pentingnya/ sederajat.
- 3) Pelayanan/asuhan terintegrasi vertikal merupakan pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan sampai ke tingkat pelayanan yang berbeda.
- 4) Manajer Pelayanan Pasien (MPP) berperan dalam mengintegrasikan pelayanan dan asuhan melalui komunikasi dengan para PPA.
- 5) Rencana asuhan oleh PPA didokumentasikan menggunakan metode pengkajian IAR (Informasi, Analisis, Rencana)

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi berfokus pada pasien dan mencakup elemen sebagai berikut:
 - a. DPJP sebagai pimpinan klinis/ketua tim PPA (Clinical Leader)
 - b. PPA bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, dibantu a.l. dengan panduan praktik klinis (PPK), panduan asuhan PPA lainnya, alur klinis /clinical pathway terintegrasi, algoritma, protocol, procedure, standing order, dan CPPT
 - c. Manajer pelayanan Pasien (MPP)/case manager menjaga kesinambungan pelayanan



- d. Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA harus memastikan :
1. Asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar atas pengkajian
 2. Rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien
 3. Respon pasien terhadap asuhan dipantau, dan
 4. Rencana asuhan dimodifikasi bila perlu berdasarkan respon pasien
- 2) Pelaksanaan prosedur dan Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan instruksi PPA dan terdapat alasan dilakukan procedure atau Tindakan medis serta hasil dari tindakan tersebut di dokumentasikan di dalam rekam medis pasien
- 3) Di rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko, termasuk pasien yang dirujuk dari luar, juga harus dilakukan pengkajian serta pencatatannya dalam rekam medis.

BAB V

RENCANA ASUHAN

Pasal 7

- 1) Pengkajian awal pasien dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA).
- 2) Rencana asuhan pasien dilakukan kepada setiap pasien setelah diterima sebagai pasien rawat inap dalam waktu 24 jam berdasarkan hasil pengkajian awal
- 3) Pengkajian awal pasien rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat meliputi pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, pengkajian pasien dari aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, kultural dan spiritual pasien.
- 4) Dalam pengkajian awal juga dilakukan
 - a. pengkajian risiko nutrisi, dan
 - b. kebutuhan fungsional dan risiko jatuh,
 - c. skrining nyeri, dan dilakukan pengkajian nyeri bila ada nyeri.
- 5) Bila diperlukan, pengkajian awal dilengkapi dengan pengkajian tambahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pasien.
- 6) Rencana asuhan juga harus di evaluasi secara berkala, direvisi dan di mutakhirkan oleh setiap PPA serta di verifikasi harian oleh DPJP sebagai ketua tim.
- 7) Rencana asuhan pasien harus dengan sasaran sesuai kebutuhan dan kondisi pasien

BAB VI

PENGKAJIAN ULANG

Pasal 8

- 1) Hasil pengkajian ulang dicatat di rekam medis dan di dokumentasikan dengan baik dan dapat dengan cepat dan mudah ditemukan kembali dalam rekam medis.
- 2) Pengkajian ulang oleh dokter penanggung jawab



pelayanan (DPJP), perawat dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk evaluasi respons pasien terhadap asuhan yang diberikan sebagai tindak lanjut.

- 3) Pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut
- 4) Pengkajian ulang oleh perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien.
- 5) Pengkajian ulang oleh profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit.
- 6) Rumah sakit menetapkan pengaturan urutan penyimpanan lembar-lembar RM agar mudah dicari kembali diakses dan terstandar, profesional pemberi asuhan (PPA) dapat menemukan dan mencari kembali hasil pengkajian di rekam medis.
- 7) Pengkajian ulang dicatat di dokumen Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi

BAB VII

PPA

Pasal 9

- 1) RS menetapkan kewenangan pemberian instruksi oleh PPA yang kompeten, tata cara pemberian instruksi dan pendokumentasiannya.
- 2) Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang melakukan pengkajian, pengkajian ulang dan pengkajian gawat darurat.
- 3) Pengkajian, pengkajian ulang dan pengkajian gawat darurat hanya dilaksanakan oleh medis yang kompeten dan berwenang.
- 4) Dokter penanggung jawab yang kompeten dan berwenang pada pelayanan anestesi melakukan pengkajian pra-induksi.
- 5) PPA yang kompeten dan berwenang membuat instruksi dengan cara yang seragam dan didokumentasikan di CPPT di kolom instruksi atau kolom SOAP

Pasal 10

- 1) Pada pelaksanaan asuhan pasien, staf klinis harus memperhatikan hak pasien;
- 2) Pemberian asuhan pasien harus dengan menghargai agama, keyakinan dan nilai-nilai pribadi pasien;
- 3) Sesuai kebutuhan pasien, dapat dilayani permintaan kompleks terkait dukungan agama atau bimbingan kerohanian.
- 4) Dalam proses asuhan, pasien atau keluarga dapat mengajukan second opinion tanpa rasa khawatir akan memengaruhi proses asuhannya.
- 5) Pengaturan pelayanan keperawatan 24 jam, termasuk perawat operan (hand over)



Pasal 11

- 1) Dari hasil pengkajian, pasien berhak mendapat informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- 2) Staf klinis menjelaskan setiap tindakan atau prosedur yang diusulkan kepada pasien dan keluarga, dan informasi yang diberikan memuat elemen:
- 3) Diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) dan dasar diagnosis;
 - a. kondisi pasien;
 - b. tindakan yang diusulkan;
 - c. tata cara dan tujuan tindakan;
 - d. manfaat dan risiko tindakan;
 - e. nama orang mengerjakan tindakan;
 - f. kemungkinan alternatif dari tindakan;
 - g. prognosis dari tindakan;
 - h. kemungkinan hasil yang tidak terduga;
 - i. kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan;
 - j. Pasien dijelaskan tentang hasil asuhan dan pengobatan, termasuk hasil asuhan dan pengobatan yang tidak terduga.

Pasal 12

- 1) Di unit / instalasi gawat darurat, dokter jaga menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan ke gawat darurat. Kemudian selanjutnya saat di konsul / rujuk di tempat (on side) atau lisan ke dokter spesialis, dan dokter spesialis tersebut memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tersebut telah menjadi DPJP pasien yang bersangkutan.
- 2) Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Ke semua DPJP tersebut bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi (dibedakan dengan “bekerja sendiri-sendiri”).
- 3) Pada pasien rawat inap, sejak awal pengambilan kesimpulan sementara, dokter dapat menyampaikan kepada pasien kemungkinan untuk dirujuk kepada sejawat lain karena alasan kompetensi.
- 4) Rujukan dimaksud dapat bersifat advis, rawat bersama atau alih rawat. Pada saat meminta persetujuan pasien untuk dirujuk, dokter harus memberi penjelasan tentang alasan, tujuan dan konsekuensi rujukan termasuk biaya, seluruh usaha ditujukan untuk kepentingan pasien.
- 5) Pasien berhak memilih dokter rujukan, dan dalam rawat bersama harus ditetapkan dokter penanggung jawab utama.
- 6) Dokter yang merujuk dan dokter penerima rujukan, harus mengungkapkan segala informasi tentang kondisi pasien yang relevan dan disampaikan secara tertulis serta bersifat rahasia.



BAB VIII

HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN ASUHAN

Pasal 13

- 1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga
- 2) Pasien memiliki hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan pada keluarga atau pihak lain
- 3) Semua staf memperoleh edukasi dan memahami tentang hak serta kewajiban pasien dan keluarga
- 4) Staf bertanggung jawab melindungi hak pasien.

Pasal 14

- 1) Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agama dan memahami agama, keyakinan, nilai-nilai pribadi pasien, serta menghormati dan menerapkan dalam asuhan pasien yang diberikan
- 2) Rumah sakit menanggapi permintaan rutin termasuk permintaan kompleks terkait dukungan agama dengan memfasilitasi bimbingan kerokhanian di rumah sakit

Pasal 15

- 1) Rumah sakit mengatur tentang kewajiban simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien
- 2) Pasien diberitahu bahwa segala informasi tentang kesehatan pasien adalah rahasia dan kerahasiaan itu akan dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Pasien harus diminta persetujuannya untuk pelepasan informasi medis
- 4) Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien
- 5) Staf mampu mengidentifikasi dan menghormati harapan dan kebutuhan privasi saat wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur, pengobatan, dan transfer pasien

Pasal 16

- 1) Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus dikarenakan kondisi pasien tertentu yang tidak mampu menjaga barang miliknya saat di rumah sakit.
- 2) Staf mampu menjelaskan tanggung jawabnya dalam menjaga barang milik pasien tersebut kepada pasien

Pasal 17

Rumah sakit melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan di antaranya ruang bayi, kamar operasi dan kasir (pembayaran)



Pasal 18

- 1) Pasien dan keluarga ikut berpartisipasi dalam proses asuhan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya
- 2) Staf dilatih dan terlatih melaksanakan perannya dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan

Pasal 19

- 1) Pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga
- 2) Pasien diberi informasi tentang kondisi medis mereka dan diagnosis pasti
- 3) Pasien diberi informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
- 4) Pasien dijelaskan bila ada tindakan yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan menjelaskan proses memberikan persetujuan
- 5) Pasien dijelaskan hasil yang diharapkan maupun kemungkinan hasil tidak terduga dari proses asuhan dan pengobatan
- 6) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan

Pasal 20

- 1) Rumah sakit mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA
- 2) Pasien dijelaskan diagnosis, kondisi pasien, tindakan yang diusulkan, tata cara dan tujuan tindakan, manfaat dan risiko tindakan, DPJP pelaksana tindakan, kemungkinan alternatif dari tindakan, prognosis, kemungkinan hasil yang tidak terduga serta kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan
- 3) DPJP, PPJA, dan PPA harus memperkenalkan diri setiap bertemu pasien

Pasal 21

- 1) Pasien serta keluarganya berhak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan
- 2) Pasien dan keluarga dijelaskan konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan harus bertanggung jawab terkait dengan keputusan tersebut
- 3) Pasien dan keluarga dijelaskan tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan



Pasal 22

Rumah sakit menetapkan peraturan pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan budaya masyarakat.

BAB IX

ALUR PASIEN

Pasal 23

- 1) Untuk menghindari penumpukan di unit gawat darurat disediakan ruang transit rawat inap.
- 2) Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, pengkajian dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dilaksanakan agar dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien.
- 3) Komponen dari pengelolaan alur pasien meliputi:
 - a. ketersediaan tempat tidur rawat inap;
 - b. Perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
 - c. Perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;
 - d. Alur pasien di tempat pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca- anestesi);
 - e. Efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi);
 - f. Pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - g. Akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

BAB X

PENUNDAAN PELAYANAN

Pasal 24

- 1) Apabila terjadi penundaan dan kelambatan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap harus disampaikan kepada pasien;
- 2) Pasien diberi tahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien dan dicatat di rekam medis.



BAB XI

KESINAMBUNGAN PELAYANAN

Pasal 25

- 1) Proses dan pelaksanaan untuk mendukung kesinambungan dan koordinasi asuhan, termasuk paling sedikit;
 - a. Pelayanan darurat dan penerimaan rawat inap;
 - b. Pelayanan diagnostik dan tindakan;
 - c. Pelayanan bedah dan non bedah;
 - d. Pelayanan rawat jalan;
- 2) Ada penunjukkan MPP dengan uraian tugas antara lain dalam konteks menjaga kesinambungan dan koordinasi pelayanan bagi individu pasien melalui komunikasi dan kerjasama dengan PPA dan pimpinan unit serta mencakup:
 - a. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien;
 - b. mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien;
 - c. mengoptimalkan proses reimbursemen; dan dengan fungsi sebagai berikut:
 1. pengkajian untuk manajemen pelayanan pasien;
 2. perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien;
 3. komunikasi dan koordinasi;
 4. edukasi dan advokasi;
 5. kendali mutu dan biaya pelayanan pasien
- 3) Pasien diskriminasi untuk kebutuhan pelayanan manajemen pelayanan pasien.
- 4) Pasien yang mendapat pelayanan MPP, pencatatannya dilakukan dalam Form MPP selalu diperbaharui untuk menjamin komunikasi dengan PPA.
- 5) Kesinambungan dan koordinasi proses pelayanan didukung dengan menggunakan perangkat pendukung, seperti rencana asuhan PPA, catatan MPP dan panduan.
- 6) Kesinambungan dan koordinasi dapat dibuktikan di semua tingkat/fase asuhan pasien.

BAB XII

PEMULANGAN PASIEN

Pasal 26

- 1) Untuk menjamin kesinambungan pelayanan dan asuhan pasien, harus dilakukan rencana pemulangan pasien yang terintegrasi;
- 2) Perencanaan pemulangan pasien dilaksanakan oleh DPJP;
- 3) Selama perawatan di rumah sakit, pasien hanya bisa meninggalkan rumah sakit atas persetujuan DPJP;
- 4) Bila diperlukan, pada pemulangan pasien dapat dirujuk kepada fasilitas kesehatan, baik perorangan ataupun institusi dimana pasien berada yang bertujuan untuk memberikan kelanjutan pelayanan atau asuhan;



- 5) Rencana pemulangan pasien dilakukan pada pasien yang rencana pemulangannya kompleks;
- 6) Rencana pemulangan yang kompleks dimulai segera setelah pasien masuk rawat inap;
- 7) Kriteria pasien yang pemulangannya kompleks adalah:
 - a. Bayi kurang bulan dengan berat badan lahir rendah;
 - b. Pasien usia lanjut dengan dementia;
 - c. Pasien dengan gangguan mobilitas sehingga tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk aktivitas kesehariannya;
 - d. Pasien yang masih memerlukan pertolongan untuk melanjutkan terapi atau perawatan.

Pasal 27

- 1) Tidak ada pasien yang diizinkan untuk keluar meninggalkan rumah sakit selama periode waktu tertentu (cuti) untuk keperluan penting.
- 2) Pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara pasien seorang pelajar/ mahasiswa yang sedang mengikuti ujian nasional dan yang serupa.
- 3) Pasien yang meninggalkan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan dipulangkan dengan cara atas permintaan sendiri (APS).

Pasal 28

- 1) Pasien rawat inap dan rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri) dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis.
- 2) Rumah sakit melakukan identifikasi pasien menderita penyakit yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.
- 3) Rumah sakit melaporkan ke pada pihak yang berwenang bila ada indikasi kondisi pasien yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan.

BAB XIII

KRITERIA PASIEN RAWAT JALAN YANG KOMPLEKS

Pasal 29

- 1) Pasien rawat jalan dengan asuhan yang kompleks atau yang diagnosisnya kompleks diperlukan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ).
- 2) Pasien rawat jalan yang memerlukan PRMRJ adalah:
 - a. Pasien dengan diagnosis yang kompleks;
 - b. Pasien dengan asuhan yang kompleks.
- 3) Penyimpanan berkas PRMRJ harus mudah untuk dicari kembali;
- 4) Informasi penting yang dimasukkan ke dalam PRMRJ diidentifikasi oleh DPJP.
- 5) Pelaksanaan pembuatan PRMRJ dievaluasi agar dapat memenuhi kebutuhan para DPJP serta untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.



BAB XIV

PENOLAKAN ASUHAN MEDIS

Pasal 30

- 1) Pengelolaan pasien rawat jalan dan rawat inap yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri dan pasien yang menghendaki penghentian pengobatan.
- 2) Pemberian edukasi kepada pasien tentang risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap tertulis di rekam medis.
- 3) Pasien keluar rumah sakit atas permintaan sendiri, tetapi tetap mengikuti proses pemulangan pasien.
- 4) Dokter keluarga (bila ada) atau dokter yang memberi asuhan berikutnya dari pasien diberitahu tentang kondisi tersebut.
- 5) Ada dokumentasi rumah sakit melakukan pengkajian untuk mengetahui alasan pasien keluar rumah sakit atas apakah permintaan sendiri, menolak asuhan medis, atau tidak melanjutkan program pengobatan.

Pasal 31

- 1) Pasien mempunyai hak untuk memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- 2) Kepada pasien atau keluarga yang menolak asuhan atau meminta penghentian asuhan/pengobatan, termasuk pulang atas permintaan sendiri, harus dijelaskan konsekuensi dari keputusan mereka;
- 3) Penjelasan juga meliputi risiko medis yang belum lengkap;
- 4) Untuk pasien yang keluar rumah sakit atas permintaan sendiri tetap harus diupayakan kesinambungan asuhannya, termasuk melalui rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di area domisili pasien;
- 5) Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap alasan penolakan asuhan medis, termasuk pasien yang pulang atas permintaan sendiri.

Pasal 32

- 1) Keluarga pasien dapat meminta dokter untuk melakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup atau meminta menilai keadaan pasien untuk penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup.
- 2) Keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup tindakan kedokteran terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh Komite Medik atau Komite Etik.
- 3) Permintaan keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pasien tidak kompeten tetapi telah mewasiatkan pesannya tentang hal ini (advanced directive) yang



dapat berupa:

- 1) Pesan spesifik yang menyatakan agar dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup apabila mencapai keadaan futility (kesia-siaan)
- 2) Pesan yang menyatakan agar keputusan didelegasikan kepada seseorang tertentu (surrogate decision maker)
- b. Pasien yang tidak kompeten dan belum berwasiat, namun keluarga pasien yakin bahwa seandainya pasien kompeten akan memutuskan seperti itu, berdasarkan kepercayaannya dan nilai-nilai yang dianutnya
- 4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bila pasien masih mampu membuat keputusan dan menyatakan keinginannya sendiri.
- 5) Dalam hal permintaan dinyatakan oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permintaan pasien tersebut harus dipenuhi.
- 6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara permintaan keluarga dan rekomendasi tim yang ditunjuk oleh komite medik atau komite etik, dimana keluarga tetap meminta penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup, tanggung jawab hukum ada di pihak keluarga.

BAB XV

TRANSFER INTRAHOSPITAL

Pasal 33

- 1) Ada regulasi tentang proses triage berbasis bukti.
- 2) Ada pelaksanaan penggunaan proses triage berbasis bukti yang dipergunakan untuk memprioritaskan pasien yang sesuai dengan kegawatannya.
- 3) Staf sudah terlatih menggunakan kriteria.
- 4) Pasien dengan kebutuhan mendesak diberikan prioritas.
- 5) Kondisi pasien distabilisasi sebelum ditransfer atau dirujuk dan didokumentasikan.

Pasal 34

- 1) Ada regulasi tentang transfer pasien antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dilengkapi dengan form transfer pasien.
- 2) Form tersebut memuat indikasi pasien masuk dirawat.
- 3) Form tersebut memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik.
- 4) Form tersebut memuat diagnosis yang dibuat
- 5) Form tersebut memuat prosedur yang dilakukan.
- 6) Form tersebut memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan.
- 7) Form tersebut memuat keadaan pasien pada waktu dipindah (transfer).
- 8) Ketentuan tersebut dilaksanakan.



BAB XVI

RUJUKAN

Pasal 35

- 1) Rujukan dilaksanakan atas persetujuan pasien atau keluarga;
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- 3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan; dan
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 36

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan rujukan adalah:

- 1) melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- 2) melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- 3) membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 37

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- 1) identitas pasien;
- 2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- 3) diagnosis kerja;
- 4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- 5) tujuan rujukan; dan
- 6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 38

- 1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien;
- 2) Selama proses transportasi rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;



- 3) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

Pasal 39

Pasien atau keluarga diberi penjelasan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan.

BAB XVII

LAYANAN TELEMEDICINE, HOMECARE, DAN HOMEVISIT

TELEMEDICINE

Pasal 40

- 1) Layanan telemedicine dilaksanakan atas permintaan pasien
- 2) Layanan yang dimaksud di ayat 1 merupakan layanan telekonsultasi klinis yaitu pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan/ saran tatalaksana. Layanan ini dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video.
- 3) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- 1) Rumah Sakit menetapkan sumber daya manusia dalam pelayanan telemedicine, menetapkan standar prosedur operasional pelayanan Telemedicine, serta menyiapkan sarana prasana yang dibutuhkan untuk menunjang layanan.
- 2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. tenaga kesehatan lain yang kompeten
- 3) Sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan ruang yang digunakan dalam melakukan Pelayanan Telemedicine, dapat berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan
- 4) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi listrik, jaringan internet yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung pelayanan telemedicine seperti aplikasi komunikasi daring.

Pasal 42

- 1) Pemberi konsultasi harus menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau menerbitkan *Expertise* kepada pasien yang meminta layanan telemedicine
- 2) Jawaban konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan medis dari dokter dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap tindakan atau penatalaksanaan pasien pada pelayanan telekonsultasi klinis
- 3) Jawaban konsultasi harus didokumentasikan dan merupakan bagian dari rekam medis pasien.
- 4) Jawaban konsultasi harus berupa informasi yang benar,



jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *expertise*

- 5) Rumah Sakit wajib menjaga kerahasiaan data pasien peminta konsultasi

Pasal 43

- 1) Biaya layanan telemedicine dibebankan kepada pasien peminta konsultasi
- 2) Besaran biaya layanan telemedicine ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit.

HOME VISIT DAN HOME CARE

Pasal 44

- 1) *Home Visit* (Kunjungan Rumah) dilakukan oleh dokter umum dan perawat kepada pasien yang meminta kunjungan ke tempat tinggal pasien untuk dilakukan konsultasi, pemeriksaan fisik dan tatalaksana sesuai kompetensi dokter umum
- 2) *Home Care* (Layanan Rumah) dilakukan oleh perawat dan/atau tenaga medis lain untuk melakukan layanan sesuai kompetensi
- 3) Prinsip pelayanan *Home Visit* dan *Home Care* adalah pelayanan yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dan berdasarkan permintaan pasien

Pasal 45

- 1) Jenis pelayanan *home visit* dan *home care* terdiri atas:
 - a. kunjungan pelayanan pasca perawatan di Rumah Sakit
 - b. kunjungan pelayanan di rumah pada kasus penyakit dengan kondisi khusus
- 2) Kunjungan pelayanan pasca perawatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu pemberian pelayanan pada pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah perawatan di Rumah Sakit dalam memaksimalkan proses penyembuhan pasien dengan kriteria:
 - a. pasien dengan penyakit risiko tinggi
 - b. pasca stroke
 - c. penyakit degenerative
 - d. luka diabetic
 - e. luka pasca bedah
 - f. pasca persalinan
 - g. penyakit lain berdasarkan pertimbangan tim *Home Visit* dan *Home Care*.
- 3) Kunjungan pelayanan di rumah pada kasus penyakit dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu pasien yang tidak mampu untuk datang ke Rumah Sakit dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. lanjut usia
 - b. penyakit berisiko menular
 - c. penyakit degenerative



- d. penyakit kronis
- e. penyandang disabilitas
- f. penyakit lain berdasarkan pertimbangan tim *Home Visit* dan *Home Care*.

Pasal 46

- 1) Biaya layanan *home visit* dan *home care* dibebankan kepada pasien peminta konsultasi
- 2) Besaran biaya layanan *home visit* dan *home care* ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit.
- 3)

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 115/I-PER/DIR/I/2018 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 48

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 12 Agustus 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 1068.1/I-PDM/DIR/VIII/2024
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN DAN
ASUHAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah sakit seyogyanya mempertimbangkan bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pemberi asuhan dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kontinuitas pelayanan.

Maksud dan tujuan adalah menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelayanan yang sudah tersedia di rumah sakit, mengoordinasikan pelayanan, kemudian merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya.

Sebagai hasilnya adalah meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit. Perlu informasi penting untuk membuat keputusan yang benar tentang kebutuhan pasien yang dapat dilayani oleh rumah sakit, pemberian pelayanan yang efisien kepada pasien, rujukan ke pelayanan lain baik di dalam maupun keluar rumah sakit, pemulangan pasien yang tepat dan aman ke rumah.

Panduan ini disusun untuk memudahkan rumah sakit mengelola penyelenggaraan pelayanan dan asuhan oleh professional pemberi asuhan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien adalah untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi professional pemberi asuhan (PPA) dalam memberikan pelayanan dan asuhan terintegrasi pada pasien.

1.2.2 Tujuan

Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien bertujuan agar pelayanan asuhan pasien dilaksanakan secara profesional sesuai peraturan perundangan-undangan serta berlangsung dengan aman dan lancar serta pelaksanaannya sangat memperhatikan keselamatan pasien serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

1.3 SASARAN

- 1) Tercapainya pelayanan dan asuhan pasien yang seragam di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada
- 2) Tercapainya pelayanan dan asuhan pasien yang terintegrasi antar PPA di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien meliputi: emergensi, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus (ICU, HCU, Hemodialisis).

1.5 PENGERTIAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Staf klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung pada pasien.

Profesional Pemberi Asuhan adalah staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien.

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya.

Perawat Penanggung Jawab Asuhan adalah perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.

Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnose.

Telemedicine adalah pemberian pelayanan Kesehatan jarak jauh oleh professional Kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan Pendidikan berkelanjutan penyedia layanan Kesehatan untuk kepentingan peningkatan Kesehatan individu dan masyarakat.

Homecare merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan pada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan Kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit. Layanan homecare dilakukan oleh perawat untuk melakukan tindakan tertentu sesuai kompetensi perawat.

Homevisit adalah kunjungan ke tempat tinggal pasien yang dilakukan oleh dokter umum dan perawat untuk melakukan pemeriksaan dasar dan tatalaksana sesuai kompetensi dokter umum.

BAB II

SKRINING

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penerimaan pasien dirawat inap atau pemeriksaan pasien dirawat jalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai dengan misi serta sumber daya rumah sakit yang ada menyesuaikan kebutuhan pasien dengan misi dan sumber daya rumah sakit bergantung pada informasi yang didapat tentang kebutuhan pasien dan kondisinya lewat skrining pada kontak pertama.

Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisis, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imaging sebelumnya.

Skrining dapat terjadi di tempat pasien, ambulans, atau waktu pasien tiba di rumah sakit. Keputusan untuk mengobati, mengirim, atau merujuk dibuat setelah ada evaluasi hasil skrining. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanannya maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan.

Rumah sakit dapat menentukan tes atau bentuk penyaringan tertentu untuk populasi pasien tertentu sebelum ditetapkan pasien dapat dilayani. Misalnya, pasien diare aktif harus diperiksa *Clostridium difficile* atau pasien tertentu diperiksa *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap methicillin. Tes spesifik tertentu atau evaluasi tertentu dilakukan jika rumah sakit mengharuskannya, sebelum diputuskan dapat dilayani dirawat inap atau terdaftar di unit rawat jalan.

Skrining merupakan pengenalan dini secara pro-aktif untuk menemukan adanya masalah atau faktor risiko. Sehingga skrining bisa dikatakan sebagai usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas, dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang yang terlihat sehat, atau benar-benar sehat tapi sesungguhnya menderita kelainan ataupun gangguan kesehatan. Skrining pada pasien dapat dilaksanakan melalui kriteria triage, anamnesis (wawancara riwayat penyakit), evaluasi visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik maupun psikologik, laboratorium klinik, ataupun radiologi diagnostik.

Skrining pasien adalah suatu rangkaian kegiatan melakukan penilaian awal kegawatdaruratan pada setiap pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat. Dalam hal ini skrining pasien dilakukan pada awal di triage primer yang juga meliputi cara mendiagnosis serta memilah penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia.

Kegiatan skrining sangat diperlukan dalam pelayanan gawat darurat karena Instalasi Gawat Darurat sebagai pusat pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam berfungsi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini yang sesuai terhadap kasus-kasus kegawatdaruratan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah skrining pasien yang baik sehingga pelayanan kesehatan untuk kasus-kasus gawat dan darurat dapat diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam kegiatan skrining pasien awal di triage primer, antara lain:

1. Triage.

Pengelompokan pasien berdasarkan atas berat ringannya trauma/ penyakit serta kecepatan penanganan/pemindahannya.

2. Prioritas.

Penentuan mana yang harus didahulukan mengenai penanganan dan pemindahan yang

mengacu tingkat ancaman jiwa yang timbul.

3. Survei primer.

Deteksi cepat dan koreksi segera terhadap kondisi yang mengancam jiwa.

4. Survei sekunder.

Melengkapi survei primer dengan mencari perubahan-perubahan anatomi yang akan berkembang sehingga mungkin akan dapat menjadi semakin parah dan memperberat perubahan fungsi vital yang ada dan berakhir dengan mengancam jiwa bila tidak segera diatasi.

5. Pasien gawat darurat.

Pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya.

6. Pasien gawat tidak darurat.

Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat (misalnya kanker stadium lanjut).

7. Pasien darurat tidak gawat.

Pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya (misalnya luka sayat dangkal).

8. Pasien tidak gawat tidak darurat.

Pasien yang tidak memerlukan pertolongan segera (misalnya pasien dengan ulcus tropicum, TBC kulit, dan sebagainya)

9. Kecelakaan (accident).

Suatu kejadian di mana terjadi interaksi berbagai faktor yang datang secara mendadak, tidak dikehendaki sehingga dapat menimbulkan cedera fisik, mental, ataupun sosial.

Kecelakaan dapat diklasifikasikan menurut kriteria sebagai berikut :

a. Mekanisme kejadian.

Tertumbuk, jatuh, terpotong, tercekik, tersengat, terbakar (baik karena efek kimia, fisik, listrik, atau maupun radiasi).

b. Tempat kejadian.

- 1) Kecelakaan lalu lintas
- 2) Kecelakaan di lingkungan rumah tangga
- 3) Kecelakaan di lingkungan pekerjaan
- 4) Kecelakaan di sekolah
- 5) Kecelakaan di tempat-tempat umum lain (ex: di tempat rekreasi, perbelanjaan, area olahraga, dsb)

c. Waktu kejadian

- 1) Waktu perjalanan (travelling / transport time).
- 2) Waktu bekerja, sekolah, bermain, dan sebagainya

10. Bencana.

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan pertolongan dan bantuan.

2.1 SKRINNING

Petugas Instalasi Gawat Darurat harus dapat menyeleksi pasien sesuai dengan kondisi kegawatdaruratannya sebagai prioritas pertama pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pelayanan pasien gawat darurat yang berlaku dan tidak berdasarkan urutan kedatangan pasien untuk kemudian memilah pasien

berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Ruang lingkup pelayanan pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat berdasarkan kondisi kegawatdaruratannya meliputi :

A. Pasien dengan kasus emergency, yaitu pasien yang berada dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat darurat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan bisa menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan yang tepat secepatnya.
- 2) Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat.
- 3) Pasien akibat musibah/kejadian yang tiba-tiba terjadi, tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya.

B. Pasien dengan kasus false emergency, yaitu pasien yang tidak memerlukan pertolongan segera. Dalam kegiatan skrining pasien awal di triage primer, perlu dipahami bahwa kematian dapat terjadi bila seseorang mengalami kerusakan atau kegagalan dari salah satu sistem atau organ di bawah ini, yaitu:

- 1) Susunan saraf pusat.
- 2) Pernafasan.
- 3) Kardiovaskuler.
- 4) Hati.
- 5) Ginjal.
- 6) Pankreas.

Kegagalan dari salah satu sistem atau organ tersebut dapat disebabkan oleh :

- 1) Trauma/cedera.
- 2) Infeksi
- 3) Keracunan.
- 4) Degenerasi (failure).
- 5) Asfiksia.
- 6) Kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah yang besar (excessive loss of water and elektrolit).

C. Lain-lain.

Pada pasien tertentu di mana penyakit yang diderita tidak termasuk di dalam daftar tersebut di atas, penentuan kasus gawat atau tidak gawat ditentukan oleh dokter yang menangani pasien.

Kegagalan sistem susunan saraf pusat, kardiovaskuler, pernafasan, dan hipoglikemia dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Sedangkan kegagalan sistem organ yang lain dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang relatif lebih lama.

Dengan demikian keberhasilan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) dalam mencegah kematian dan cacat ditentukan oleh:

- 1) Kecepatan menemukan penderita gawat darurat
- 2) Kecepatan meminta pertolongan
- 3) Kecepatan dan kualitas pertolongan yang diberikan:
- 4) Di tempat kejadian
- 5) Dalam perjalanan ke rumah sakit
- 6) Pertolongan selanjutnya secara mantap dirumah sakit

2.2 SKRINNING PASIEN DENGAN KETERBATASAN FISIK

Macam-Macam / Jenis-Jenis Kecacatan atau Kelainan Pada Manusia:

A. Buta (Tuna Netra)

Pasien buta adalah pasien yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Pasien yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

B. Tuli (Tuna Rungu)

Pasien tuli adalah Pasien yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana Pasien normal pada umumnya. Pasien yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.

C. Bisu (Tuna Wicara)

Pasien bisu adalah Pasien yang tidak bisa berbicara dengan Pasien lain. Pasien yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Pasien bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

D. Cacat Fisik (Tuna Daksa)

Pasien yang tuna daksa adalah Pasien yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.

E. Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita)

Pasien yang tuna grahita adalah Pasien yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras)

Pasien yang tuna laras adalah Pasien yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu Pasien yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

G. Cacat Kombinasi (Tuna Ganda)

Pasien yang tuna ganda adalah Pasien yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti Pasien yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau Pasien yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.

2.3 SKRINNING WILAYAH

Skrining bisa dilakukan saat pasien berada di luar Rumah Sakit tempat asal rujukan pasien, pada saat pasien ditransportasi, dan pada saat pasien tiba di RS (IGD atau IRJ).

BAB III

TRIAGE

Pasien darurat, sangat mendesak, atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi menggunakan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan kebutuhan pasien yang mendesak dengan mendahulukan dari pasien yang lain. Pada kondisi bencana dapat menggunakan triase bencana. Sesudah dinyatakan pasien darurat, mendesak, dan membutuhkan pertolongan segera maka dilakukan pengkajian dan menerima pelayanan secepat- cepatnya. Kriteria psikologis dibutuhkan dalam proses triase. Pelatihan bagi staf diadakan agar staf mampu memutuskan pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan pelayanan yang dibutuhkan.

Pada waktu skrining dan pasien diputuskan diterima untuk rawat inap, proses pengkajian membantu staf mengetahui prioritas kebutuhan pasien untuk pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan pasien. Pelayanan preventif (dalam proses admisi) adalah untuk mencegah perburukan/ komplikasi, misalnya antara lain kasus luka tusuk dalam diberikan ATS dan kasus luka bakar derajat berat dimasukkan ke unit luka bakar.

Jika rumah sakit tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan kondisi darurat, pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang fasilitas pelayanannya dapat memenuhi kebutuhan pasien. Sebelum ditransfer atau dirujuk pasien harus dalam keadaan stabil dan dilengkapi dengan dokumen pencatatan.

Sebagai prioritas pertama pelayanan kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pelayanan pasien gawat darurat yang berlaku dan tidak berdasarkan urutan kedatangan pasien.

Pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat diseleksi berdasarkan kondisi kegawatdaruratannya dengan menggunakan Australian Triage Scale (ATS) sebagai berikut :

- A. ATS 1 adalah kondisi yang mengancam jiwa (atau resiko besar mengalami kemunduran) dan perlu intervensi yang cepat dan agresif.
- B. ATS 2 adalah :
 - 1) pasien dengan kondisi yang cukup serius atau mengalami kemerosotan secara cepat yang apabila tidak ditangani dalam 10 menit dapat mengancam jiwa atau mengakibatkan kegagalan organ.
 - 2) pasien yang dengan pemberian obat yang dimana hasil akhirnya sangat tergantung dari seberapa cepat obat itu diterima oleh pasien (misalnya : trombolisis, antiracun)
- C. ATS 3 adalah pasien yang datang dengan kondisi yang mungkin akan berkembang menjadi mengancam nyawa atau menimbulkan kecacatan bila tidak ditangani dalam waktu 30 menit
- D. ATS 4 adalah pasien dengan kondisi yang dapat mengalami kemerosotan atau akan menghasilkan outcome yang berbeda bila dalam 1 jam pasien belum ditangani. Gejala berkepanjangan.
- E. ATS 5 adalah kondisi pasien yang sudah kronis dengangejala yang minor, dimana hasil akhirnya tidak akan berbeda bila penanganan ditunda sampe 2 jam setelah kedatangan.

Adapun berikut ini adalah berbagai kondisi yang dapat dikategorikan termasuk sebagai kasus emergency, antara lain :

- A. ATS 1 :
 - 1) Henti Jantung

-
- 2) Henti Napas
 - 3) Resiko sumbatan jalan napas
 - 4) Frekuensi pernapasan (RR) < 10x/menit
 - 5) Distress / Kesukaran pernapasan yang sangat berat (extreme)
 - 6) Tekanan darah < 80 (dewasa) atau syok pada anak/bayi
 - 7) Tidak respon atau hanya respon nyeri (GCS < 9)
 - 8) Kejang terus menerus atau berkepanjangan
 - 9) Overdosis IV dan tidak responsif atau hipoventilasi
 - 10) Gangguan perilaku berat dengan ancaman segera terhadap kekerasan yang berbahaya

B. ATS 2 :

- 1) Resiko Jalan Napas – Stridor berat atau produksi air liur berlebih yang membahayakan
- 2) Distress/ kesukaran pernapasan berat
- 3) Gangguan Sirkulasi :Kulit berkeringat atau berubah warna karena perfusi yang buruk
Detak jantung < 50 atau > 150 (dewasa), Hipotensi dengan gangguan hemodinamik
Kehilangan darah hebat, Nyeri dada kardiak
- 4) Nyeri sangat hebat – apapun penyebabnya
- 5) Kadar Gula Darah < 2 mmol/l
- 6) Mengantuk, penurunan respon (GCS < 13)
- 7) Hemiparesis / disfasia akut
- 8) Demam dengan tanda-tanda letargi (semua umur)
- 9) Terkena zat asam atau basa pada mata – membutuhkan irigasi
- 10) Multitrauma mayor (membutuhkan respon cepat dari tim terorganisasi)
- 11) Trauma lokal berat – Fraktur mayor, amputasi
- 12) Riwayat penyakit resiko tinggi
- 13) Konsumsi obat penenang atau zat toksik lainnya secara signifikan
- 14) Envenomation (tergigit hewan beracun) yang signifikan / berbahaya
- 15) Nyeri hebat yang memberi kesan adanya Pre eklampsia, AAA (Abdominal Aortic Aneurysm) / Aneurisma Aorta Abdominalis, atau Kehamilan ektopik
- 16) Perilaku / Psikiatrik: Kasar atau agresif Ancaman langsung terhadap diri sendiri atau orang lain Membutuhkan pengekangan
- 17) Agitasi atau agresi berat

C. ATS 3 :

- 1) Hipertensi berat
- 2) Kehilangan cukup banyak darah – apapun penyebabnya
- 3) Sesak napas sedang
- 4) Saturasi O₂ 90 – 95
- 5) Kadar Gula Darah > 16 mmol/l
- 6) Riwayat kejang (saat ini sadar)
- 7) Semua demam pada pasien immunosupresi misalnya pasien onkologi, Rx steroid
- 8) Muntah terus menerus
- 9) Dehidrasi
- 10) Cedera kepala dengan kehilangan kesadaran yang singkat – saat ini sadar
- 11) Nyeri sedang sampai berat – apapun penyebabnya, yang membutuhkan analgesik
- 12) Nyeri dada non-kardiak dengan tingkat keparahan sedang
- 13) Nyeri perut tanpa ciri-ciri resiko tinggi – tingkat keparahan sedang atau pasien usia >

65 tahun

- 14) Trauma ekstremitas sedang – deformitas, laserasi yang parah,
- 15) Ekstremitas – Perubahan sensasi, tidak ada pulsasi
- 16) Trauma – Riwayat penyakit resiko tinggi tanpa resiko tinggi lainnya
- 17) Neonatus stabil
- 18) Anak beresiko
- 19) Perilaku / Psikiatrik: Sangat tertekan, resiko menyakiti diri sendiri Psikotik akut atau gangguan pikiran, Krisis situasional, sengaja menyakiti diri sendiri Agitasi / menarik diri / berpotensi agresif

D. ATS 4 :

- 1) Perdarahan ringan
- 2) Aspirasi benda asing, tanpa distress pernapasan
- 3) Cedera dada tanpa nyeri pada tulang iga atau distress pernapasan
- 4) Kesulitan menelan, tanpa distress pernapasan
- 5) Cedera kepala ringan, tidak kehilangan kesadaran
- 6) Nyeri sedang, dengan beberapa faktor risiko
- 7) Muntah atau diare tanpa dehidrasi
- 8) Inflamasi atau benda asing pada mata – penglihatan normal
- 9) Trauma ekstremitas minor – pergelangan kaki terkilir, kemungkinan patah tulang, laserasi tidak terkomplikasi yang membutuhkan investigasi atau intervensi – tanda vital normal, nyeri ringan / sedang
- 10) Gips terlalu ketat, tanpa kerusakan neurovaskuler
- 11) Sendi bengkak dan panas
- 12) Nyeri perut tidak spesifik
- 13) Perilaku / Psikiatrik :Masalah kesehatan mental semi-urgent, Dalam observasi dan/atau tidak ada resiko langsung terhadap diri sendiri maupun orang lain

E. ATS 5 :

- 1) Nyeri minimal tanpa ciri-ciri beresiko tinggi
- 2) Riwayat penyakit resiko rendah dan saat ini asimtomatik
- 3) Gejala minor dari penyakit stabil yang ada
- 4) Gejala minor dari kondisi dengan resiko rendah
- 5) Luka minor – lecet kecil, laserasi ringan (tidak membutuhkan jahitan)
- 6) Dijadwalkan kontrol misalnya pada kontrol luka, perban kompleks
- 7) Imunisasi
- 8) Perilaku / Psikiatrik : Pasien yang dikenal dengan gejala kronis Krisis sosial, pasien baik secara klinis
- 9) Untuk pasien anak-anak digunakan standard yang berbeda, karena kondisi pada anak jauh lebih berbahaya daripada dewasa

TRIASE ANAK < 6 BULAN

	RESIKO TINGGI	RESIKO SEDANG
Pemberian makanan	<1/2 normal	½ - 2/3 normal
Arousal/Tingkat Kewaspadaan (SSP)	Sering Mengantuk Penurunan Aktivitas Konvulsi Tangisan Lemah	Kadang Mengantuk
Pernapasan	Apnea atau Sianosis	Sesak napas
Sirkulasi	Kulit pucat dan panas	Kulit pucat
Output Cairan	Muntah Kehijauan <4x popok basah/hari	>5x Muntah dalam 24 jam Kencing kurang dari biasanya
Feses	Tinja Berdarah	-

Proses triage dimulai ketika pasien masuk ke pintu IGD. Perawat triage harus mulai memperkenalkan diri, kemudian menanyakan riwayat singkat dan melakukan pengkajian, misalnya terlihat sekilas kearah pasien yang berada di brankar sebelum mengarahkan ke ruang perawatan yang tepat.

Pengumpulan data subjektif dan objektif harus dilakukan dengan cepat, tidak lebih dari 5 menit karena pengkajian ini tidak termasuk pengkajian perawat utama. Perawat triage bertanggung jawab untuk menempatkan pasien di area pengobatan yang tepat, misalnya bagian trauma dengan peralatan khusus, bagian jantung dengan monitor jantung dan tekanan darah, dll. Tanpa memikirkan dimana pasien pertama kali ditempatkan setelah triage, setiap pasien tersebut harus dikaji ulang oleh perawat utama sedikitnya sekali setiap 60 menit.

Untuk pasien yang dikategorikan sebagai pasien yang mendesak atau gawat darurat, pengkajian dilakukan setiap 15 menit/lebih bila perlu. Setiap pengkajian ulang harus didokumentasikan dalam rekam medis. Informasi baru dapat mengubah kategorisasi keakutan dan lokasi pasien di area pengobatan. Misalnya kebutuhan untuk memindahkan pasien yang awalnya berada di area pengobatan minor ke tempat tidur bermonitor ketika pasien tampak mual atau mengalami sesak napas, sinkope, atau diaphoresis (Iyer, 2004).

Bila kondisi pasien ketika datang sudah tampak tanda-tanda objektif bahwa ia mengalami gangguan pada airway, breathing, dan circulation, maka pasien ditangani terlebih dahulu. Pengkajian awal hanya didasarkan atas data objektif dan data subjektif sekunder dari pihak keluarga. Setelah keadaan pasien membaik, data pengkajian kemudian dilengkapi dengan data subjektif yang berasal langsung dari pasien (data primer).

Alur dalam proses Triage:

- 1) Pasien datang diterima petugas / paramedis IGD
- 2) Diruang triase dilakukan anamneses dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya oleh perawat.
- 3) Bila jumlah penderita / korban yang ada lebih dari 50 orang, maka triase dapat dilakukan di luar ruang triase (di depan gedung IGD)

- 4) Setelah diseleksi, dilakukan tindakan sebagai berikut :
- a. Ditangani di tempat periksa/tempat tindakan sesuai dengan kondisi klinisnya (bedah/non-bedah/obstetriginekologi).
 - b. Jika didapatkan kegawatdaruratan yang mengarah pada kondisi cardiac arrest dan/atau respiratory arrest segera ditangani di ruang resusitasi ATS 1.
 - c. Jika pasien yang datang termasuk ATS 4 dan ATS 5 datang pada jam kerja maka diarahkan ke Instalasi Rawat Jalan untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi klinisnya dan bilamana perlu dianjurkan untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Jika pasien datang di luar jam kerja maka dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi klinisnya setelah kasus-kasus gawat darurat terlayani.
 - d. Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia (death on arrival). Dipastikan terlebih dahulu bahwa pasien memang sudah meninggal dunia, untuk kemudian bilamana perlu dibawa ke kamar jenazah.

KATEGORI	WAKTU RESPON MAXIMUM
ATS 1	Segera
ATS 2	10 menit
ATS 3	30 menit
ATS 4	60 menit
ATS 5	120 menit

BAB IV

ASUHAN PASIEN

Asuhan pasien dilakukan oleh PPA dan staf klinis yang kompeten dan berwenang. Asuhan pasien dapat berupa upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau rehabilitatif termasuk anestesia, tindakan bedah, pengobatan, terapi suportif, atau kombinasinya, yang berdasarkan hasil pengkajian dan pengkajian ulang pasien.

Pelaksanaan asuhan dan pelayanan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh semua PPA, dan dapat dibantu oleh staf klinis lainnya. Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat asuhan yang sama/seragam di rumah sakit.

Asuhan pasien yang seragam terefleksi dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan tidak bergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembayaran.
- 2) Akses untuk mendapatkan asuhan dan pengobatan yang diberikan oleh PPA yang kompeten tidak tergantung pada hari atau jam yaitu 7 (tujuh) hari, 24 (dua puluh empat) jam
- 3) Kondisi pasien menentukan sumber daya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhannya
- 4) Pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, sama di semua unit pelayanan di RS misalnya pelayanan anastesi
- 5) Pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan yang sama akan menerima tingkat asuhan keperawatan yang sama di semua unit pelayanan di RS

Keseragaman dalam memberikan asuhan pada semua pasien akan menghasilkan penggunaan sumber daya yang efektif dan memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang sama di semua unit pelayanan rumah sakit.

Pelayanan dan asuhan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk pelayanan dan asuhan pasien terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pelayanan/asuhan terintegrasi horizontal melibatkan kontribusi PPA yang sama pentingnya/ sederajat. Pelayanan/asuhan terintegrasi vertikal merupakan pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan sampai ke tingkat pelayanan yang berbeda. Manajer Pelayanan Pasien (MPP) berperan dalam mengintegrasikan pelayanan dan asuhan melalui komunikasi dengan para PPA.

Rencana asuhan oleh PPA di dokumentasikan menggunakan metode pengkajian IAR (Informasi, Analisis, Rencana):

- 1) I (Informasi) : Informasi dikumpulkan termasuk di dalamnya berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostic / lain, dsb (pengkajian awal)
- 2) A (Analisis Informasi) : menetapkan diagnose, masalah, risiko untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien (pengkajian ulang/SOAP)
- 3) R (Rencana Asuhan) : Merumuskan rencana dan sasaran terukur untuk memenuhi kebutuhan yan pasien (Tenaga Gizi / ADIME (Assement, Diagnosis, Intervention, Monitoring, Evaluation))

Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi berfokus pada pasien dan mencakup elemen sebagai berikut:

- 1) DPJP sebagai pimpinan klinis/ketua tim PPA (Clinical Leader)
- 2) PPA bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin dengan kolaborasi interprofessional,

dibantu a.l. dengan panduan praktik klinis (PPK), panduan asuhan PPA lainnya, alur klinis /clinical pathway terintegrasi, algoritma, protocol, procedure, standing order, dan CPPT

- 3) Manajer pelayanan Pasien (MPP)/case manager menjaga kesinambungan pelayanan
- 4) Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA harus memastikan :
 - a. Asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar atas pengkajian
 - b. Rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien
 - c. Respon pasien terhadap asuhan dipantau, dan
 - d. Rencana asuhan dimodifikasi bila perlu berdasarkan respon pasien

Proses pelayanan dan asuhan pasien (PAP) bersifat dinamis dan melibatkan banyak PPA dan berbagai unit pelayanan. Agar proses PAP menjadi efisien, penggunaan SDM dan sumber lainnya menjadi efektif, dan hasil akhir kondisi pasien menjadi lebih baik maka diperlukan integrasi dan koordinasi. Kepala unit pelayanan menggunakan cara untuk melakukan integrasi dan koordinasi pelayanan serta asuhan lebih baik (misalnya, pemberian asuhan pasien secara tim oleh para PPA, ronde pasien multidisiplin, formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT), dan manajer pelayanan pasien/case manager. Instruksi PPA dibutuhkan dalam pemberian asuhan pasien misalnya instruksi pemeriksaan di lab (termasuk Patologi Anatomi), pemberian obat, asuhan keperawatan khusus, terapi nutrisi, dan lain2. Instruksi ini harus tersedia dan mudah diakses sehingga dapat ditindaklanjuti tepat waktu misalnya dengan menuliskan instruksi pada formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dalam rekam medis atau didokumentasikan dalam elektronik rekam medik agar staf memahami kapan instruksi harus dilakukan, dan siapa yg akan melaksanakan instruksi tersebut.

Setiap RS harus mengatur dalam regulasinya:

- 1) Instruksi seperti apa yg harus tertulis/didokumentasikan (bukan instruksi melalui telepon atau instruksi lisan saat PPA yang memberi instruksi sedang berada di tempat/RS), antara lain:
 - a. Instruksi yang diijinkan melalui telepon terbatas pada situasi darurat dan ketika dokter tidak berada di tempat/di RS.
 - b. Instruksi verbal diijinkan terbatas pada situasi dimana dokter yang memberi instruksi sedang melakukan tindakan/prosedur steril.
- 2) Permintaan pemeriksaan lab (termasuk pemeriksaan Patologi Anatomi) dan diagnostik imaging tertentu harus disertai indikasi klinik.
- 3) Pengecualian dalam kondisi khusus, misalnya di unit darurat dan unit intensif.
- 4) Siapa yg diberi kewenangan memberi instruksi dan perintah catat di dalam berkas rekam medik/system elektronik rekam medik sesuai regulasi RS.

Prosedur diagnostik dan tindakan klinis, yang dilakukan sesuai instruksi serta hasilnya didokumentasikan di dalam rekam medis pasien. Contoh prosedur dan tindakan misalnya endoskopi, kateterisasi jantung, terapi radiasi, pemeriksaan Computerized Tomography (CT), dan tindakan serta prosedur diagnostik invasif dan non-invasif lainnya. Informasi mengenai siapa yang meminta dilakukannya prosedur atau tindakan, dan alasan dilakukannya prosedur atau tindakan tersebut didokumentasikan dalam rekam medik.

Di rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko, termasuk pasien yang dirujuk dari luar, juga harus dilakukan pengkajian serta pencatatannya dalam rekam medis.

BAB V

RENCANA ASUHAN

5.1 PENGKAJIAN AWAL

Pengkajian yang efektif menghasilkan keputusan tentang tindakan segera dan berkelanjutan yang dibutuhkan pasien untuk tindakan darurat, asuhan terencana, bahkan jika kondisi pasien berubah. Pengkajian pasien merupakan proses berkelanjutan, dinamis dan dikerjakan di instalasi / unit gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan unit pelayanan lainnya

Isi minimal pengkajian awal antara lain :

- A. status fisik,
- B. psiko-sosio-spiritual,
- C. ekonomi
- D. riwayat kesehatan pasien.
- E. riwayat alergi,
- F. pengkajian nyeri,
- G. risiko jatuh,
- H. Pengkajian fungsional,
- I. risiko nutrisi,
- J. kebutuhan edukasi
- K. Perencanaan Pemulangan Pasien

Jika pasien sudah terdaftar atau diterima di rumah sakit untuk asuhan rawat inap dan atau rawat jalan, sebuah pengkajian lengkap perlu dilakukan terkait alasan pasien datang di rumah sakit mengacu kepada butir-butir isi minimal pengkajian awal. Informasi spesifik yang dibutuhkan rumah sakit pada tahap ini, prosedur yang dilakukan padanya, tergantung kebutuhan pasien dan dimana asuhan diberikan (misalnya, asuhan rawat inap atau rawat jalan). Rumah sakit menetapkan regulasi proses pengkajian dan pendokumentasiannya di rekam medis.

Untuk melakukan pengkajian pasien secara efektif, rumah sakit menentukan regulasi, isi minimal pengkajian yang harus dilakukan oleh dokter, perawat dan profesional pemberi asuhan lainnya. Pengkajian dilakukan oleh disiplin klinis sesuai kebutuhan. Pengkajian hanya dilakukan oleh orang yang kompeten dan diberi kewenangan sesuai peraturan perundang- undangan. Seluruh hasil pengkajian itu harus ada sebelum dilakukan pengobatan.

Pengkajian awal seorang pasien, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat merupakan proses yang penting untuk identifikasi kebutuhan pasien untuk memulai proses asuhan pasien.

Proses pengkajian awal memberikan informasi perihal:

1. Pemahaman asuhan yang diinginkan oleh pasien
2. Pemilihan asuhan paling baik untuk pasien
3. Diagnosis awal, dan
4. Pemahaman respons pasien terhadap asuhan sebelumnya

Pengkajian awal pasien dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA). Pengkajian awal pasien rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat meliputi pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, pengkajian

pasien dari aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, kultural dan spiritual pasien.

Dalam pengkajian awal juga dilakukan:

1. pengkajian risiko nutrisi, nutrisi,
2. kebutuhan fungsional dan risiko jatuh,
3. skrining nyeri, dan dilakukan pengkajian nyeri bila ada nyeri.

Bila diperlukan, pengkajian awal dilengkapi dengan pengkajian tambahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pasien.

5.2 RENCANA ASUHAN

Di unit / instalasi gawat darurat, dokter jaga menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan kegawat-daruratan. Kemudian selanjutnya saat dikonsul / rujuk ditempat (on side) atau lisan ke dokter spesialis, dan dokter spesialis tersebut memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tersebut telah menjadi DPJP pasien yang bersangkutan, sehingga DPJP berganti.

Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua DPJP tersebut bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi (dibedakan dengan “bekerja sendiri-sendiri”).

Rencana asuhan merangkum asuhan dan pengobatan/tindakan yg akan diberikan kepada seorang pasien. Rencana asuhan memuat satu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPA untuk menegakkan atau mendukung diagnosis yg disusun dari hasil pengkajian. Tujuan utama rencana asuhan adalah memperoleh hasil klinis yg optimal.

Proses perencanaan bersifat kolaboratif menggunakan data yang berasal dari pengkajian awal dan pengkajian ulang yang di buat oleh para PPA (dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan lainlainnya). Rencana asuhan dibuat setelah melakukan pengkajian awal dalam waktu 24 jam terhitung sejak pasien diterima sebagai pasien rawat inap. Rencana asuhan yang baik menjelaskan asuhan pasien yang objektif dan memiliki sasaran yang dapat diukur untuk memudahkan pengkajian ulang serta mengkaji atau merevisi rencana asuhan. Pasien dan keluarga dapat dilibatkan dalam proses perencanaan asuhan. Rencana asuhan harus disertai target terukur, misalnya:

- a. Detak jantung, irama jantung, dan tekanan darah menjadi normal atau sesuai dgn rencana yg ditetapkan;
- b. Pasien mampu menyuntik sendiri insulin sebelum pulang dari RS;
- c. Pasien mampu berjalan dengan “walker” (alat bantu untuk berjalan).

Berdasarkan hasil pengkajian ulang, rencana asuhan diperbaharui utk dapat menggambarkan kondisi pasien terkini. Rencana asuhan pasien harus terkait dgn kebutuhan pasien. Kebutuhan ini mungkin berubah sbg hasil dari proses penyembuhan klinis atau terdapat informasi baru hasil pengkajian ulang (contoh, hilangnya kesadaran, hasil laboratorium yang abnormal). Rencana asuhan dan revisinya didokumentasikan dlm rekam medis pasien sbg rencana asuhan baru.

DPJP sbg ketua tim PPA melakukan evaluasi / revaluasi berkala dan verifikasi harian untuk memantau terlaksananya asuhan secara terintegrasi dan membuat notasi sesuai dgn kebutuhan. Satu rencana asuhan terintegrasi dengan sasaran2 yg diharapkan oleh PPA lebih baik dari pada rencana terpisah oleh masing2 PPA. Rencana asuhan yg baik menjelaskan asuhan individual, objektif, dan sasaran dapat diukur utk memudahkan pengkajian ulang serta revisi rencana asuhan

Pada pasien rawat inap, sejak awal pengambilan kesimpulan sementara, dokter dapat menyampaikan kepada pasien kemungkinan untuk dirujuk kepada sejawat lain karena alasan kompetensi.

Rujukan dimaksud dapat bersifat advis, rawat bersama atau alih rawat. Pada saat meminta persetujuan pasien untuk dirujuk, dokter harus memberi penjelasan tentang alasan, tujuan dan konsekuensi rujukan termasuk biaya, seluruh usaha ditujukan untuk kepentingan pasien.

Pasien berhak memilih dokter rujukan, dan dalam rawat bersama harus ditetapkan dokter penanggung jawab utama. Dokter yang merujuk dan dokter penerima rujukan, harus mengungkapkan segala informasi tentang kondisi pasien yang relevan dan disampaikan secara tertulis serta bersifat rahasia.

BAB VI

PENGKAJIAN ULANG

Pengkajian ulang oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) merupakan faktor penting untuk evaluasi terhadap keputusan tentang asuhannya sudah benar dan efektif. Dilakukan pengkajian ulang dengan interval waktu yang didasarkan atas kebutuhan dan rencana asuhan, dan digunakan sebagai dasar rencana pulang pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Hasil pengkajian ulang dicatat di rekam medik pasien/CPPT sebagai informasi untuk di gunakan oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA).

Pengkajian ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) memperhitungkan asuhan pasien selanjutnya. Seorang dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) melakukan pengkajian terhadap pasien akut sekurang-kurangnya setiap hari, termasuk di akhir minggu/libur, dan jika ada perubahan penting kondisi pasien.

Pengkajian ulang dilakukan dan dicatat di CPPT berbasis IAR dengan metode SOAP, gizi dapat dengan metode ADIME, dengan memperhatikan:

1. Interval sepanjang asuhan pasien (contoh, perawat mencatat secara tetap, tanda-tanda vital (TTV), pengkajian nyeri, detak jantung dan suara paru, sesuai kondisi pasien).
2. Setiap hari oleh dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) terhadap pasien sebagai respons terhadap perubahan penting kondisi pasien.
3. Jika diagnosis pasien berubah dan dibutuhkan perubahan rencana asuhan.
4. Menentukan apakah pengobatan dan tindakan lain berhasil dan pasien dapat dipindah atau pulang.

Hasil pengkajian ulang dicatat di rekam medik pasien/CPPT sebagai informasi utk digunakan oleh semua PPA. CPPT yang disusun mencakup 5 kolom yaitu:

1. kolom tanggal dan jam
2. kolom profesional pemberi asuhan,
3. kolom hasil pengkajian pasien dan pemberian pelayanan (Tulis dengan format SOAP/ADIME, disertai sasaran. Tulis nama, beri paraf pada akhir catatan),
4. kolom Instruksi PPA termasuk pasca bedah (Instruksi ditulis dengan rinci dan jelas),
5. kolom review & verifikasi DPJP (tuliskan nama, beri paraf, tanggal, jam). DPJP harus membaca/mereview seluruh rencana asuhan.

Temuan pada pengkajian digunakan sepanjang proses pelayanan untuk mengevaluasi kemajuan pasien dan untuk memahami kebutuhan untuk pengkajian ulang. Oleh karena itu sangat perlu bahwa pengkajian medis, keperawatan dan pengkajian profesional pemberi asuhan (PPA) lain yang benar, dicatat dan didokumentasikan dengan baik dan dapat dengan cepat dan mudah ditemukan kembali dalam rekam medis atau dari lokasi lain yang ditentukan standar dan digunakan oleh staf yang melayani pasien.

PPA

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang melakukan pengkajian, pengkajian ulang dan pengkajian gawat darurat, yakni dokter umum dan perawat IGD. Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang pada pelayanan anestesi melakukan pengkajian pra-induksi.

NO.	PENGKAJIAN	DOKTER UMUM	DPJP	PERAWAT	AHLI GIZI	APOTEKER
1	Pengkajian medis rawat inap		V			
2	Pengkajian Keperawatan Rawat Inap			V		
3	Pengkajian Keperawatan ICU			V		
4	Pengkajian medis rawat jalan umum	V				
5	Pengkajian medis rawat jalan spesialis		V			
6	Pengkajian keperawatan rawat jalan			V		
7	Pengkajian IGD	V				
8	Pengkajian Keperawatan IGD			V		
9	Pengkajian medis rawat inap bedah		V			
10	Pengkajian keperawatan pre bedah			V		
	Pengkajian keperawatan durante operasi					
	Pengkajian keperawatan post operasi					

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang melakukan pengkajian prasedasi sebagai berikut:

- 19

atas sedasi yang diterapkan;

4. Pemberian sedasi secara aman; dan
5. Mengevaluasi serta menyimpulkan temuan monitor selama dan sesudah sedasi.

Berikut tata laksana PPA yang berwenang melakukan pengkajian awal dan pengkajian ulang:

1. Profesional Pemberi Asuhan melakukan pengkajian awal terhadap pasien di IGD, poli, dan di rawat inap.
2. Dokter umum melakukan pengkajian awal medis Gawat Darurat di IGD, pasien dengan kondisi kritis diberikan prioritas untuk pengkajian dan tindakan.
3. Dokter umum dan gigi melakukan pengkajian awal medis rawat jalan di poli umum rawat jalan
4. Dokter Spesialis selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien melakukan pengkajian awal medis rawat jalan spesialis di poli spesialis, dan pengkajian awal medis rawat inap di instalasi rawat inap.
5. Dokter Anastesi melakukan pengkajian pra induksi, dan pra sedasi pada pasien pre operasi di rawat inap.
6. Perawat melakukan pengkajian awal keperawatan yang mencakup skrining nyeri, skrining gizi, risiko jatuh, status fungsional sesuai lokasi, yakni:
 - a. pengkajian keperawatan gawat darurat di IGD
 - b. Pengkajian keperawatan intensive care di ICU
 - c. pengkajian keperawatan rawat inap di IRNA
 - d. pengkajian keperawatan rawat jalan di IRJA
 - e. pengkajian keperawatan bedah di Kamar operasi
7. Pasien rawat jalan dengan penyakit akut /non kronis, pengkajian awal diperbaharui setelah 1 (satu) bulan. Pasien rawat jalan dengan penyakit kronis, pengkajian awal diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan.
8. Pada pasien rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko harus dilakukan pengkajian serta pencatatannya dalam rekam medis.
9. Seluruh hasil pengkajian itu harus ada sebelum dilakukan pengobatan.
10. pengkajian ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) terhadap pasien akut sekurang-kurangnya setiap hari, termasuk di akhir minggu/libur, dan jika ada perubahan penting kondisi pasien
11. Prosedure dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan intruksi PPA
12. Intruksi di buat oleh PPA yang kompeten dan berwenang dengan cara yang seragam dan didokumentasikan di CPPT di kolom instruksi atau kolom SOAP

BAB VIII

HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN ASUHAN

8.1 HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Kepemimpinan (leadership) rumah sakit bertanggung jawab bagaimana memperlakukan pasiennya dan pimpinan perlu mengetahui serta memahami hak pasien dan keluarga juga tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pimpinan rumah sakit memberikan arahan kepada kelompok staf medis (KSM) dan staf klinis lainnya di unit pelayanan untuk memastikan semua staf di rumah sakit ikut bertanggung jawab melindungi hak-hak ini.

Rumah sakit menghormati hak dan kewajiban pasien, serta dalam banyak hal menghormati keluarga pasien, terutama hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan kepada keluarga atau pihak lain terkait asuhan pasien. Sebagai contoh, pasien tidak ingin diagnosis dirinya disampaikan kepada keluarga.

Hak serta kewajiban pasien dan keluarga merupakan elemen dasar dari semua interaksi di rumah sakit, staf rumah sakit, pasien, dan keluarga. Oleh karena itu, harus ada regulasi yang memastikan semua staf sadar dan tanggap terhadap isu hak serta kewajiban pasien dan keluarga pada waktu berinteraksi saat memberikan asuhan kepada pasien.

Hak pasien dan keluarga adalah hak pasien dan keluarga sesuai yang tertulis dalam Undang- Undang pasal 32 Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi , adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standart profesi.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisiensi sehingga pasien terhidar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengna keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang di deritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang di derita termasuk data – data medisnya.
10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara medis , tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan yang di lakukan.
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan di lakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
12. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis.
13. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan di rumah sakit.
15. Mengajukan usul , saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
16. Menolak layanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya.

17. Menggugat dan /atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit di duga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata ataupun pidana.
18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standart pelayanan media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kewajiban pasien dan keluarga (permenkes 69 tahun 2014) adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

8.2 IDENTIFIKASI AGAMA,KEYAKINAN DAN NILAI-NILAI PRIBADI

Pasien dengan populasi yang beragam dalam memeluk agama, keyakinan, dan memiliki nilai-nilai pribadi maka beragam pula dalam menerima proses asuhan. Beberapa agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi berlaku umum bagi semua pasien serta biasanya berasal dari budaya dan agama. Ada keyakinan yang bersifat individual. Rumah sakit melakukan identifikasi agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi pasien agar dalam memberikan asuhan selaras dengan agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi.

Asuhan pasien yang menghargai agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi akan membantu kelancaran proses asuhan serta memberikan hasil asuhan yang lebih baik. Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agama dan memahami agama, keyakinan, nilai-nilai pribadi pasien, serta menerapkan dalam asuhan pasien yang diberikan.

Jika pasien atau keluarga ingin berbicara dengan seseorang terkait kebutuhan agama dan spiritualnya maka rumah sakit menetapkan proses untuk menjawab permintaan ini. Proses ini dilaksanakan melalui staf kerohanian di rumah sakit.

Proses ini menjadi kompleks bila rumah sakit atau negara tidak mengakui secara resmi atau mempunyai sumber terkait sebuah agama, tetapi bila ada permintaan ini maka rumah sakit dapat mengambil sumber di luar rumah sakit atau dari keluarga

8.3 HAK PRIVASI PASIEN

Staf wajib menjaga dan menghargai informasi tentang pasien sebagai suatu kerahasiaan, di samping itu juga menghormati kebutuhan privasi pasien. Pada implementasinya rumah sakit diminta tidak mencantumkan informasi rahasia pasien pada pintu pasien, lobby atau ruang perawat dan tidak mengadakan diskusi yang terkait dengan pasien di ruang publik.

Staf menyadari peraturan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan informasi serta memberitahukan pasien bagaimana rumah sakit menghargai kerahasiaan informasi dan privasi mereka. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) memberitahu pada pasien atau keluarga tentang informasi kondisi pasien di setiap terjadi perubahan.

Rumah sakit memiliki kebijakan yang menunjukkan apakah pasien memiliki akses terhadap informasi kesehatan mereka dan proses untuk mendapatkan akses jika diizinkan.

Rumah sakit diminta menghormati hak privasi pasien terutama ketika diwawancara, diperiksa, dirawat, dan dipindahkan. Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindung dari para staf, pasien lain, masyarakat, dan bahkan dari anggota keluarga. Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam, atau diikutsertakan dalam survei wawancara tentang penelitian dan lainnya. Meskipun ada beberapa cara pendekatan umum untuk memberikan privasi bagi seluruh pasien, setiap pasien memiliki harapan privasi yang berbeda atau tambahan privasi sesuai dengan kebutuhan privasi pasien.

Harapan akan kebutuhan ini mungkin saja berubah seiring dengan waktu dan kondisi. Oleh karena itu, rumah sakit mengidentifikasi kebutuhan privasi pasien terkait dengan asuhan pasien. Informasi medis dan kesehatan lainnya ketika didokumentasikan dan dikumpulkan bersifat penting guna memahami pasien dan kebutuhannya serta memberikan perawatan dan pelayanan seiring dengan waktu. Informasi ini dapat berupa kertas atau elektronik atau kombinasi dari keduanya.

Rumah sakit menghargai informasi tersebut sebagai rahasia dan menerapkan regulasi yang melindungi informasi tersebut dari kehilangan atau penyalahgunaan. Regulasi yang ada mencakup informasi yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang- undangan

8.4 PENYIMPANAN BARANG MILIK PASIEN

Rumah sakit memberitahu pasien tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap barang milik pasien dan batasan-batasannya. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap barang milik pasien yang dibawa masuk ke rumah sakit sesuai dengan batasan. Rumah sakit memiliki proses untuk mengidentifikasi dan melindungi barang milik pasien yang ditiptkan atau pasien tidak dapat menjaganya untuk memastikan barang tidak hilang atau dicuri. Proses ini berlaku untuk pasien di unit darurat, pasien pelayanan satu hari (one day care), rawat inap, pasien yang tidak mampu menjaga barang miliknya, dan mereka yang tidak mampu membuat keputusan tentang barang miliknya.

8.5 IDENTIFIKASI POPULASI DENGAN RESIKO KEKERASAN

Rumah sakit mengidentifikasi kelompok pasien berisiko yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, misalnya bayi, anak-anak, pasien cacat, manula, pascabedah, gangguan jiwa, gangguan kesadaran, dan lain-lain serta menetapkan tingkat perlindungan terhadap pasien tersebut. Perlindungan ini mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup hal-hal terkait keamanan, seperti kelalaian dalam asuhan, tidak memberi layanan, atau tidak memberi bantuan waktu terjadi kebakaran. Semua anggota staf memahami tanggung jawabnya dalam proses ini.

Rumah sakit menjaga keamanan dalam tiga area, yaitu :

1. Area publik yang terbuka untuk umum seperti area parkir, rawat jalan, dan penunjang pelayanan
2. Area tertutup yang hanya dapat dimasuki orang tertentu dengan izin khusus dan pakaian tertentu, misalnya kamar operasi

3. Area semiterbuka, yaitu area yang terbuka pada saat-saat tertentu dan tertutup pada saat yang lain, misalnya rawat inap pada saat jam berkunjung menjadi area terbuka, tetapi di luar jam berkunjung menjadi area tertutup untuk itu pengunjung di luar jam berkunjung harus diatur, diidentifikasi, dan menggunakan identitas pengunjung.
4. Area prioritas di rumah sakit Prima Husada adalah ruang bayi, kamar operasi dan bagian pembayaran (kasir)

8.6 SECOND OPINION

Partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan melalui pengambilan keputusan tentang asuhan, bertanya soal asuhan, minta pendapat orang lain (second opinion) dan menolak prosedur diagnostik atau tindakan. Saat pasien minta second opinion diharapkan rumah sakit tidak menolak, mencegah atau menghalanginya, sebaliknya rumah sakit diminta memfasilitasi permintaan tersebut dengan jalan pasien diberi informasi tentang kondisinya, hasil tes, diagnosis, rekomendasi tindakan, dan sebagainya. Rumah sakit tidak boleh menyembunyikan informasi ini jika pasien meminta second opinion. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk mengatur hak pasien untuk mencari second opinion tanpa rasa khawatir memengaruhi proses asuhannya. Rumah sakit mendorong pasien dan keluarga terlibat dalam seluruh aspek pelayanan. Seluruh staf sudah dilatih melaksanakan regulasi dan perannya dalam mendukung hak pasien serta keluarganya untuk berpartisipasi di dalam proses asuhannya.

8.7 PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Agar pasien dan keluarganya dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan, mereka mendapat informasi tentang kondisi medis, setelah dilakukan pengkajian, termasuk diagnosis pasti dan rencana asuhan. Pasien serta keluarga mengerti hal yang harus diputuskan tentang asuhan dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam membuat keputusan. Sebagai tambahan, pasien serta keluarga harus mengerti tentang proses asuhan, tes pemeriksaan, prosedur, dan tindakan yang harus mendapat persetujuan (consent) dari mereka.

Selama dalam proses asuhan, pasien juga berhak untuk mendapat penjelasan tentang hasil pengobatan/tindakan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga. Pasien serta keluarga paham bahwa mereka berhak atas informasi ini dan berhak mengetahui siapa dokter yang bertanggungjawab untuk melayaninya yang akan memberitahu hasil asesmen dan pengobatan/tindakan.

Terkadang beberapa pasien tidak ingin mengetahui diagnosis penyakitnya atau berpartisipasi dalam membuat keputusan terkait asuhannya, tetapi mereka diberi kesempatan dan dapat memilih berpartisipasi melalui anggota keluarga, teman, atau pengganti keluarga. Bagi pasien harus jelas siapa DPJP yang akan memberi informasi tentang kondisi medik, asuhan, tindakan, dan hasil termasuk kejadian yang tidak terduga dan lain sebagainya.

Pasien dan keluarga menerima informasi tentang penyakit, rencana tindakan, dan DPJP serta para PPA lainnya agar mereka dapat memutuskan tentang asuhannya.

Anggota staf menjelaskan setiap tindakan atau prosedur yang diusulkan kepada pasien dan keluarga. Informasi yang diberikan memuat elemen:

1. diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) dan dasar diagnosis;
2. kondisi pasien;
3. tindakan yang diusulkan;
4. tata cara dan tujuan tindakan;
5. manfaat dan risiko Tindakan
6. nama orang mengerjakan tindakan;
7. kemungkinan alternatif dari tindakan;

8. prognosis dari tindakan;
9. kemungkinan hasil yang tidak terduga;
10. kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan.

Staf klinis juga memberi tahu pasien, nama dokter, atau profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya sebagai penanggung jawab asuhan pasien yang diberi izin melakukan tindakan dan prosedur. Sering, pasien bertanya tentang kompetensi, pengalaman, jangka waktu bekerja di rumah sakit, dan sebagainya dari para DPJP serta PPA lainnya. Rumah sakit harus menetapkan proses untuk menjawab jika pasien minta tambahan informasi tentang DPJP dan perawat penanggung jawab asuhan (PPJA) mereka.

8.8 HAK MENOLAK ATAU TIDAK MELANJUTKAN PENGobatan

Pasien atau mereka yang membuat keputusan atas nama pasien dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan atau pengobatan yang direncanakan atau tidak meneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatan dimulai. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk membuat keputusan, potensi hasil dari keputusan tersebut, dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. Pasien serta keluarganya diberitahu tentang alternatif pelayanan dan pengobatan.

8.9 HAK MENOLAK RESUSITASI

Keputusan menolak pelayanan resusitasi serta melanjutkan atau menolak pengobatan bantuan hidup dasar merupakan keputusan paling sulit yang dihadapi pasien, keluarga, PPA, dan rumah sakit. Tidak ada satupun proses yang dapat mengantisipasi semua situasi keputusan perlu dibuat. Karena itu, penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan pedoman dalam pembuatan keputusan yang sulit tersebut. Rumah sakit diminta membuat pedoman yang berisi :

1. rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. rumah sakit harus memastikan sesuai dengan norma agama dan budaya;
3. mencakup situasi keputusan tersebut berubah sewaktu pelayanan sedang berjalan;
4. memandu PPA melalui isu hukum dan etika dalam melaksanakan menunda atau melepas bantuan hidup dasar;
5. rumah sakit mengembangkan regulasi melalui suatu proses yang melibatkan banyak profesi dari berbagai sudut pandang;
6. regulasi tentang identifikasi tanggung jawab masing-masing pihak dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien.

BAB IX

ALUR PASIEN

Staf memahami dan mampu melaksanakan proses penerimaan pasien. Proses tersebut meliputi:

1. pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap;
2. penerimaan langsung dari unit darurat ke unit rawat inap;
3. menahan pasien untuk observasi.

Dalam rangka keterbukaan kepada publik tersedia sistem pendaftaran rawat inap dan rawat jalan secara online menggunakan billing SIMRS.

Saat diputuskan rawat inap, dokter yang memutuskan rawat inap memberi informasi tentang rencana asuhan yang diberikan, hasil asuhan yang diharapkan, termasuk penjelasan oleh petugas pendaftaran tentang perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien/keluarga. Pemberian informasi didokumentasikan.

Unit darurat yang penuh sesak dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi dapat menyebabkan pasien menumpuk di daerah unit darurat dan menciptakannya sebagai tempat menunggu sementara pasien rawat inap. Mengelola alur berbagai pasien selama menjalani asuhannya masing-masing menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukan yang selanjutnya mengganggu waktu pelayanan dan akhirnya juga berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, pengkajian dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien.

Komponen dari pengelolaan alur pasien termasuk:

1. ketersediaan tempat tidur rawat inap. Bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju pada seluruh rumah sakit pasien di transitkan pada ruangan yg tersedia dengan menyetujui pada form penundaan bersedia menunggu ruangan. Bila tidak bersedia menunggu ruangan pasien dirujuk.
2. perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;
3. perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;
4. alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca-anestesi);
5. efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumah tanggaan dan transportasi);
6. pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien;
7. akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

Monitoring dan perbaikan proses ini merupakan strategi yang tepat dan bermanfaat untuk mengatasi masalah. Semua staf rumah sakit, mulai dari unit rawat inap, unit darurat, staf medis, keperawatan, administrasi, lingkungan, dan manajemen risiko dapat ikut berperan serta menyelesaikan masalah arus pasien ini. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh seorang Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/ Case Manager.

Alur pasien menuju dan penempatannya di unit gawat darurat berpotensi membuat pasien bertumpuk. Ada penempatan pasien di unit gawat darurat yang merupakan jalan keluar sementara mengatasi penumpukan pasien rawat inap rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit harus menetapkan standar waktu berapa lama pasien di unit darurat dan di unit

intermediate, kemudian harus ditransfer ke unit rawat inap rumah sakit. Diharapkan rumah sakit dapat mengatur dan menyediakan tempat yang aman bagi pasien.

Unit yang memberikan layanan intensif (misalnya ICU, ICCU, pascaoperasi) atau unit layanan spesialisik (misalnya unit luka bakar atau transplantasi organ) merupakan unit yang mahal dan biasanya menempati ruangan dengan staf yang terbatas. Setiap rumah sakit harus menetapkan kriteria untuk menentukan pasien yang membutuhkan tingkat pelayanan yang tersedia di unit-unit tersebut.

Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan di unit spesialisik menghabiskan banyak sumber daya, rumah sakit mungkin membatasi hanya pasien dengan kondisi medis yang reversibel yang dapat diterima masuk dan pasien kondisi khusus termasuk menjelang akhir kehidupan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat konsisten maka kriteria menggunakan prioritas atau parameter diagnostik dan atau parameter objektif termasuk kriteria berbasis fisiologis.

Mereka yang berasal dari unit-unit gawat darurat, intensif, atau layanan spesialisik berpartisipasi menentukan kriteria. Kriteria dipergunakan untuk menentukan penerimaan langsung di unit, misalnya masuk dari unit darurat.

Kriteria juga digunakan untuk masuk dari unit-unit di dalam atau dari luar rumah sakit, seperti halnya pasien dipindah dari rumah sakit lain. Pasien yang diterima masuk di unit khusus memerlukan asesmen dan evaluasi ulang untuk menentukan apakah kondisi pasien berubah sehingga tidak memerlukan lagi pelayanan spesialisik. Misalnya, jika status fisiologis sudah stabil dan monitoring intensif baik, tindakan lain tidak diperlukan lagi. Atau jika kondisi pasien menjadi buruk sampai pada titik pelayanan intensif atau tindakan khusus tidak diperlukan lagi, pasien kemudian dapat dipindah ke unit layanan yang lebih rendah (seperti unit pelayanan medis atau bedah, rumah penampungan, atau unit pelayanan paliatif).

Kriteria untuk memindahkan pasien dari unit khusus ke unit pelayanan lebih rendah harus sama dengan kriteria yang dipakai untuk memindahkan pasien ke unit pelayanan berikutnya. Misalnya, jika keadaan pasien menjadi buruk sehingga pelayanan intensif dianggap tidak dapat menolong lagi maka pasien masuk ke rumah penampungan (hospices) atau ke masuk ke unit pelayanan paliatif dengan menggunakan kriteria.

Apabila rumah sakit melakukan riset atau menyediakan pelayanan spesialisik atau melaksanakan program, penerimaan pasien di program tersebut harus melalui kriteria tertentu atau ketentuan protokol. Mereka yang terlibat dalam riset atau program lain harus terlibat dalam menentukan kriteria atau protokol. Penerimaan ke dalam program tercatat di rekam medis pasien termasuk kriteria atau protokol yang diberlakukan terhadap pasien yang diterima masuk.

BAB X

PENUNDAAN PELAYANAN

Pasien diberitahu jika ada penundaan dan kelambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu. Pasien diberi informasi alasan dan sebab mengapa terjadi penundaan/kelambatan atau harus menunggu serta diberi tahu tentang alternatif yang tersedia, ketentuan ini berlaku bagi pasien rawat inap dan rawat jalan. Untuk beberapa pelayanan, seperti onkologi atau transplan tidak berlaku ketentuan tentang penundaan / kelambatan pelayanan atau tes.

Form penundaan pelayanan adalah sebagai berikut :

DPJP Pelaksana			
Tindakan			
Pemberi Informasi			
Penerima Informasi /		Sebagai.....	
Pemberi Persetujuan*			
JenisInformasi		Isi Informasi	
Jenis penundaan pelayanan		☐ Penundaan dan kelambatan pelayanan akibat kondisi pasien	
		☐ Pasien harus masuk dalam daftar tunggu kamar	
Alasan penundaan			
Alternatif yang tersedia			
Lain Lain			
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menjelaskan hal-hal tersebut di atas secara benar dan jelas serta memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi dan pasien memahami. (Pemberi Informasi)		TTD	
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana adanya di atas yang sudah diberitanda () di kolomkanannya dan saya telah memahaminya. (Pemberi Persetujuan)		TTD	
Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat			

BAB XI

KESINAMBUNGAN PASIEN

Perjalanan pasien di rumah sakit mulai dari admisi, keluar pulang, atau pindah melibatkan berbagai profesional pemberi asuhan (PPA), unit kerja, dan manajer pelayanan pasien (MPP). Selama dalam berbagai tahap pelayanan, kebutuhan pasien dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di rumah sakit dan kalau perlu sumber daya dari luar. Kesenambungan pelayanan berjalan baik jika semua pemberi pelayanan mempunyai informasi yang dibutuhkan tentang kondisi kesehatan pasien terkini dan sebelumnya agar dapat dibuat keputusan yang tepat.

Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan dengan pola pelayanan berfokus pada pasien (Patient Centered Care/ PCC). Pola ini dipayungi oleh konsep WHO.

Pelayanan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribusi profesi tiap-tiap profesional pemberi asuhan (PPA) adalah sama pentingnya atau sederajat. Pada integrasi vertikal pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang berbeda maka peranan manajer pelayanan pasien (MPP) penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang memadai terhadap profesional pemberi asuhan (PPA).

Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi berpusat pada pasien dan mencakup elemen sebagai berikut:

1. keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga.
2. dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai Ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA).
3. profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dibantu antara lain oleh Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya, Alur KlinisClinical Pathway terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, Standing Order dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi);
4. perencanaan pemulangan pasien (P3Discharge Planning Terintegrasi;
5. asuhan gizi terintegrasi
6. manajer pelayanan pasien/case manager

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) bukan merupakan profesional pemberi asuhan (PPA aktif dan dalam menjalankan manajemen pelayanan pasien mempunyai peran minimal adalah sebagai berikut:

1. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien;
2. mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien;
3. mengoptimalkan proses reimbursemen; dan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkajian untuk manajemen pelayanan pasien;
 - b. perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien;
 - c. komunikasi dan koordinasi;
 - d. edukasi dan advokasi;
 - e. kendali mutu dan biaya pelayanan pasien

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan manajemen pelayanan pasien antara lain adalah:

1. pasien mendapat asuhan sesuai dengan kebutuhannya
2. terpelihara kesinambungan pelayanan;
3. pasien memahami/mematuhi asuhan dan peningkatan kemandirian pasien;

-
4. kemampuan pasien mengambil keputusan;
 5. keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga;
 6. optimalisasi sistem pendukung pasien;
 7. pemulangan yang aman;
 8. kualitas hidup dan kepuasan pasien.

Agar kesinambungan asuhan pasien tidak terputus, rumah sakit harus menciptakan proses untuk melaksanakan kesinambungan dan koordinasi pelayanan di antara profesional pemberi asuhan (PPA), manajer pelayanan pasien (MPP), pimpinan unit, dan staf lain sesuai dengan regulasi rumah sakit di beberapa tempat:

1. Pelayanan darurat dan penerimaan rawat inap;
2. Pelayanan diagnostik dan tindakan;
3. Pelayanan bedah dan nonbedah;
4. Pelayanan rawat jalan;
5. Organisasi lain atau bentuk pelayanan lainnya.

Proses koordinasi dan kesinambungan pelayanan dibantu oleh penunjang lain seperti panduan praktik klinis, alur klinis/clinical pathways, rencana asuhan, format rujukan, daftar tilik/check list lain, dan sebagainya

PEMULANGAN PASIEN (DISCHARGE PLANNING)

Memulangan pasien ke rumah atau keluarga, didasarkan atas kondisi kesehatan pasien dan kebutuhannya untuk memperoleh kesinambungan asuhan. Dapat juga pasien dirujuk atau dikirim ke praktisi kesehatan di luar rumah sakit. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang bertanggung jawab atas asuhan pasien menentukan kesiapan pasien keluar rumah sakit berdasar atas kebijakan, kriteria, dan indikasi rujukan yang ditetapkan rumah sakit. Kebutuhan kesinambungan asuhan berarti rujukan ke dokter spesialis, rehabilitasi fisik, atau bahkan kebutuhan upaya preventif di rumah yang dikoordinasikan oleh keluarga pasien.

Dibutuhkan perencanaan untuk mengatur tindak lanjut pemulangan pasien ke praktisi kesehatan atau organisasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan kesinambungan asuhan pasien. Rumah sakit yang berada di komunitas tempat praktisi kesehatan juga berada di dalamnya membuat kerja sama formal dan informal. Jika pasien berasal dari komunitas/daerah lain maka rumah sakit akan merujuk pasien ke praktisi kesehatan yang berasal dari komunitas tempat pasien tinggal.

Berikut adalah form rencana pemulangan pasien :

Kelas / Kamar	
Nama Pasien	
Tanggal Lahir	
Tanggal Masuk	
Agama	
Alamat	
DPJP utama	
Dokter rawat bersama	1.
	2.
	3.
Diagnosis	

Discharge Risk Assessment :	
Pasien tinggal di rumah dengan support komunitas terbatas atau tinggal sendiri	☐
membutuhkan bantuan untuk manajemen pengobatan	☐
Polifarmasi (lebih dari 7 macam obat)	☐
Membutuhkan diet khusus	☐
Terpasang alat medis (NGT, Kateter Urine, CVC, Colostomy Bag, Drain, ...)	☐
Luka akut / kronis / decubitus	☐
Membutuhkan bantuan untuk manajemen oksigen / nebulizer	☐
Membutuhkan bantuan untuk Activity Daily Living	☐
Penurunan kognitif	☐
Riwayat gangguan mental	☐
Diagnosa pasien CHF, DM, COPD, HIV-AIDS	☐
Inkontinensia	☐
Kondisi terminal (end stage disease)	☐
Riwayat jatuh	☐
Ketidapatuhan terhadap rencana medis	☐
Rawat inap / kunjungan ke IGD berulang	☐
Penatalaksanaan Discharge Planning Sesuai Discharge Risk Assessment :	☐
Penatalaksanaan discharge planning sesuai dengan Discharge	☐
Risk Assessment	☐
memastikan pasien mempunyai care giver	☐
melatih pasien / care giver pasien mengenai manajemen pengobatan	☐
melatih pasien / care giver pasien mengenai perawatan luka	☐
Melatih pasien / care giver mengenai perawatan alat medis yang terpasang (NGT) / Kateter urine / CVC / Colostomy bag / Drain / ...	☐
Menginformasikan pada pasien / care giver tanda - tanda kegawatan pada pasien	☐
Menginformasikan jadwal kontrol	☐
Lain – Lain :	☐

DICHARGE PLANNING				
KEGIATAN		CATATAN		
AKTIVITAS				
☐ Jenis aktivitas yang boleh dilakukan				
☐ Prosedur				
☐ Alat bantu yang dapat digunakan				
☐ Pengobatan (obat - obatan yang sudah diresepkan untuk dilanjutkan di rumah)				
EDUKASI KESEHATAN				
☐ Jadwal Kontrol				
☐ Pemeriksaan laboratorium lanjutan				
☐ Pengertian dan pemahaman akan efek samping obat				
☐ Obat - obatan alternatif				
☐ Pencegahan terhadap kekambuhan				
☐ Lainnya				
PERAWATAN DI RUMAH				
☐ Kenali tanda dan gejala yang perlu dilaporkan				
☐ Pengobatan yang dapat dilakukan di rumah sebelum ke rumah sakit				
DIET				
☐ Anjuran pola makan				
☐ Batasan makanan				
KEBUTUHAN SPIRITUAL DAN PSIKOLOGIS				
☐ Konsultasi spiritual				
☐ Pengakuan Dosa				
☐ Petugas kedukaan				
☐ Pengadilan marah				
☐ Rekonsiliasi konflik				
☐ Kegiatan keagamaan				
RINCIAN PEMULANGAN				
☐ Tanggal pemulangan				
☐ Pendamping				
☐ Transportasi yang digunakan				
☐ Keadaan umum saat pemulangan				
DAFTAR OBAT - OBATAN				
NAMA OBAT	INDIKASI	DOSIS	CARA MIUM	WAKTU MINUM
JADWAL KONTROL DOKTER				
PERJANJIAN & PEMERIKSAAN	TANGGAL	NOMOR TELEPON		
Saya dapat menerima dan mengerti tentang intruksi pulang.				
Instruksi RENCANA PEMULANGAN PASIEN ini telah dijelaskan kepada : ☐ Pasien ☐ Keluarga ☐ Orang terdekat ☐ Lain – lain	Pasien / Keluarga	Karu/PJ Shift	MPP	
	(.....)	(.....)	(.....)	

12.2 PENANGAN PASIEN MELARIKAN DIRI

Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola pasien yang menolak rencana asuhan medis yang melarikan diri.

Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan telah selesai menjalani pemeriksaan lengkap dan sudah ada rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan, kemudian pasien ini memutuskan meninggalkan rumah sakit maka pasien ini dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Pasien rawat inap dan rawat jalan (termasuk pasien dari unit darurat) berhak menolak tindakan medis dan keluar rumah sakit. Pasien ini menghadapi risiko karena menerima pelayanan atau tindakan tidak lengkap yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian. Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan minta untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan dokter maka pasien harus diberitahu tentang risiko medis oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan dan proses keluarnya pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Jika pasien mempunyai dokter keluarga maka dokter keluarga tersebut harus diberitahu tentang keputusan pasien. Bila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Rumah sakit perlu mengetahui alasan ini agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam rangka memperbaiki proses.

Jika pasien menolak rencana asuhan medis tanpa memberi tahu siapapun di dalam rumah sakit atau ada pasien rawat jalan yang menerima pelayanan kompleks atau pelayanan untuk menyelamatkan jiwa, seperti kemoterapi atau terapi radiasi, tidak kembali ke rumah sakit maka rumah sakit harus berupaya menghubungi pasien untuk memberi tahu tentang potensi risiko bahaya yang ada.

Bila pasien masih ada dalam lingkungan rumah sakit, maka segera mengajak kembali pasien dan keluarga pasien tersebut kembali ke ruang perawatan dengan cara yang baik dan sopan. Tetapi bila pasien tidak ditemukan maka perawat segera melapor :

1. Ke keamanan secara tertulis pada buku khusus laporan keamanan dengan data pasti tentang pasien meliputi :
 - a. Nama
 - b. Alamat
 - c. Meninggalkan ruangan tanggal : Jam.....
 - d. Ciri-ciri khusus
2. Ke Kasir memberikan data perincian biaya pemakaian obat dan alkes, sewa alat, kwitansi dokter, pemeriksaan yang belum diperinci, konsultasi gizi dan lain-lain.
3. Instalasi Dapur Gizi (lisan tertulis dalam amprah makanan)
4. Kepala ruangan atau penanggungjawab ruangan melaporkan kejadian pasien kabur melalui telepon disusul laporan tertulis kronologis kejadian kepada:
 - a. Dokter yang merawat/dokter jaga.
 - b. Kepala bidang perawatan melalui kepala seksi.
 - c. Sub.Bag.Administrasi pasien (AP) dengan melaporkan data yang belum masuk :
 - 1) Pemakaian obat dan Alkes habis pakai.
 - 2) Jasa dokter
 - 3) Pemeriksaan penunjang
5. Segera :
 - a. Mencari alamat pasien yang bersangkutan.
 - b. Membuat berita acara pasien kabur
 - c. Memberitahukan kejadian tersebut ke Keuangan untuk melakukan penagihan ke alamat yang ada.

BAB XIII

KRITERIA PASIEN RAWAT JALAN KOMPLEKS

Untuk pasien rawat jalan yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau diagnosis yang kompleks dibuat catatan tersendiri Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) dan tersedia untuk PPA.

Jika rumah sakit memberikan asuhan dan tindakan berlanjut kepada pasien dengan diagnosis kompleks dan atau yang membutuhkan asuhan kompleks (misalnya, pasien yang datang beberapa kali dengan masalah kompleks, menjalani tindakan beberapa kali, datang di beberapa unit klinis, dan sebagainya) maka kemungkinan dapat bertambahnya diagnosis dan obat, perkembangan riwayat penyakit, serta temuan pada pemeriksaan fisis. Oleh karena itu, untuk kasus seperti ini harus dibuat ringkasannya. Sangat penting bagi setiap PPA yang berada di berbagai unit yang memberikan asuhan kepada pasien ini mendapat akses ke informasi Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) tersebut.

Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) memuat informasi, termasuk:

1. identifikasi pasien yang menerima asuhan kompleks atau dengan diagnosis kompleks (seperti pasien di klinis jantung dengan berbagai komorbiditas antara lain DM tipe 2, total knee replacement, gagal ginjal tahap akhir, dan sebagainya. Atau pasien di klinis neurologik dengan berbagai komorbiditas).
2. Identifikasi informasi yang dibutuhkan oleh para dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang menangani pasien tersebut
3. Menentukan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi medis yang dibutuhkan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) tersedia dalam format mudah ditelusur (easy-to-retrieve) dan mudah di-review.
4. Evaluasi hasil implementasi proses untuk mengkaji bahwa informasi dan proses memenuhi kebutuhan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien

BAB XIV

PENOLAKAN ASUHAN MEDIS

Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan telah selesai menjalani pemeriksaan lengkap dan sudah ada rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan, kemudian pasien ini memutuskan meninggalkan rumah sakit maka pasien ini dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Pasien rawat inap dan rawat jalan (termasuk pasien dari unit darurat) berhak menolak tindakan medis dan keluar rumah sakit. Pasien ini menghadapi risiko karena menerima pelayanan atau tindakan tidak lengkap yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian.

Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan minta untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan dokter maka pasien harus diberitahu tentang risiko medis oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan dan proses keluarnya pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Jika pasien mempunyai dokter keluarga maka dokter keluarga tersebut harus diberitahu tentang keputusan pasien. Bila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Rumah sakit perlu mengetahui alasan ini agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam rangka memperbaiki proses.

Jika pasien menolak rencana asuhan medis tanpa memberi tahu siapapun di dalam rumah sakit atau ada pasien rawat jalan yang menerima pelayanan kompleks atau pelayanan untuk menyelamatkan jiwa, seperti kemoterapi atau terapi radiasi, tidak kembali ke rumah sakit maka rumah sakit harus berupaya menghubungi pasien untuk memberi tahu tentang potensi risiko bahaya yang ada.

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk proses ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk rumah sakit membuat laporan ke dinas kesehatan atau kementerian kesehatan tentang kasus infeksi dan memberi informasi tentang pasien yang mungkin mencelakakan dirinya atau orang lain.

Pasien atau mereka yang membuat keputusan atas nama pasien dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan atau pengobatan yang direncanakan atau tidak meneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatan dimulai. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk membuat keputusan, potensi hasil dari keputusan tersebut, dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. Pasien serta keluarganya diberitahu tentang alternatif pelayanan dan pengobatan

BAB XV

TRANSFER INTRAHOSPITAL

Selama dirawat inap di rumah sakit, pasien mungkin dipindah dari satu pelayanan atau dari satu unit rawat inap ke berbagai unit pelayanan lain atau unit rawat inap lain. Jika profesional pemberi asuhan (PPA) berubah akibat perpindahan ini maka informasi penting terkait asuhan harus mengikuti pasien. Pemberian obat dan tindakan lain dapat berlangsung tanpa halangan dan kondisi pasien dapat dimonitor. Untuk memastikan setiap tim asuhan menerima informasi yang diperlukan maka rekam medis pasien ikut pindah atau ringkasan informasi yang ada di rekam medis disertakan waktu pasien pindah dan menyerahkan kepada tim asuhan yang menerima pasien. Ringkasan memuat sebab pasien masuk dirawat, temuan penting, diagnosis, prosedur atau tindakan, obat yang diberikan, dan keadaan pasien waktu pindah.

Bila pasien dalam pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) maka kesinambungan proses tersebut di atas dipantau, diikuti, dan transfernya disupervisi oleh manajer pelayanan pasien (MPP).

Berikut Adalah form transfer pasien antar unit :

Transfer Pasien antar unit —>				
Indikasi di rawat :				
Riwayat Kesehatan:		Pemeriksaan Fisik:		
Pemeriksaan Diagnostik :				
Diagnosis:				
Rencana : ☐ IRNA ☐ Operasi/ ODC ☐ ICU ☐ Kamar Bersalin ☐ R. Isolasi Ketersediaan kamar Ada/ Tidak:				
Prosedur / Terapi / Tindakan				
Tindakan	Petugas	Tindakan	Petugas	
☐ Pasang infus		☐ Nebul		
☐ Injeksi		☐ Kateter No		
.....		☐ Irigasi mata		
☐ Rawat luka		☐ NGT		
☐ hecting		☐		
...	...			
☐ tindakan kegawatan				

Kriteria Transfer	Derajat	Petugas	Nama Petugas
Pasien stabil membutuhkan ruang perawatan biasa	0	☐ Helper	
Pasien delirium atau orang tua	0,5	☐ Helper	
Transfer dari atau ke HCU	1	☐ Perawat ☐ Helper	
Saat ini pasien stabil berpotensi tidak stabil			

Pasien tidak stabil, penanganan kegagalan organ/ post operasi besar, membutuhkan observasi ketat	2	☐ Perawat ☐ Helper		
--	---	---	--	--

Pasien tidak stabil, Membutuhkan bantuan pernafasan dan atau dengan kegagalan organ	3	☐ Dokter ☐ Perawat ☐ Helper	
---	---	--	--

Waktu Serah Terima	Petugas Yang Menyerahkan	Petugas Yang Menerima
	Tanggal..... Pukul WIB	Tanggal..... Pukul WIB
Keadaan Pasien Waktu Dipindah		
ACC Dokter IGD	☐ Ya ☐ Tidak	
Keadaan Umum	☐ Stabil ☐ Tidak Stabil	☐ Stabil ☐ Tidak Stabil
TTV	GCS:..... TD:.....mmHg Nadi:.....x/menit RR:.....x/menit Tax:.....°C SpO2:.....Lpm	GCS:.... TD:.....mmHg Nadi:.....x/menit RR:.....x/menit Tax:.....°C SpO2:.....Lpm
Aldrete Score (bila pasien post op)		
Gelang pasien terpasang dan sesuai	☐ Sudah ☐ Belum	
Konsul DPJP	☐ Sudah ☐ Belum	
Risiko Jatuh	☐ Ada ☐ Tidak Terpasang gelang ☐ Ada ☐ Tidak	
Dokumen Rekam Medis	☐ Datang bersamaan ☐ Terlambat	
Catatan Administrasi		

Petugas yang menyerahkan pasien

(.....)

Petugas yang menerima pasien

(.....)

BAB XVI

RUJUKAN

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialisik dan tindakan, serta penunjang diagnostik. Jika pasien dirujuk ke rumah sakit lain, yang merujuk harus memastikan fasilitas kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas menerima pasien.

Diperoleh kepastian terlebih dahulu dan kesediaan menerima pasien serta persyaratan rujukan diuraikan dalam kerja sama formal atau dalam bentuk perjanjian. Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi. Rujukan terjadi juga ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal.

Rujukan pasien sesuai dengan kondisi pasien menentukan kualifikasi staf pendamping yang memonitor dan menentukan jenis peralatan medis khusus.

Selain itu, harus dipastikan fasilitas pelayanan kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas pasien dan jenis teknologi medis. Diperlukan proses konsisten melakukan rujukan pasien untuk memastikan keselamatan pasien.

Proses ini menangani :

1. ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;
2. selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;
3. dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan;
4. dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima.

Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keamanan proses rujukan untuk memastikan pasien telah ditransfer dengan staf yang kompeten dan dengan peralatan medis yang tepat.

Informasi tentang pasien dirujuk disertakan bersama dengan pasien untuk menjamin kesinambungan asuhan.

Dokumen rujukan berisi sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

1. identitas pasien;
2. hasil pemeriksaan (anamesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
3. diagnosis kerja.
4. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
5. tujuan rujukan;
6. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan rujukan. Dokumentasi juga memuat nama fasilitas pelayanan kesehatan dan nama orang di fasilitas pelayanan kesehatan yang menyetujui menerima pasien, kondisi khusus untuk rujukan (seperti kalau ruangan tersedia di penerima rujukan atau tentang status pasien). Juga

dicatat jika kondisi pasien atau kondisi pasien berubah selama ditransfer (misalnya, pasien meninggal atau membutuhkan resusitasi).

Dokumen lain yang diminta sesuai dengan kebijakan rumah sakit (misalnya, tanda tangan perawat atau dokter yang menerima serta nama orang yang memonitor pasien dalam perjalanan rujukan) masuk dalam catatan.

Dokumen rujukan diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan penerima bersama dengan pasien. Catatan setiap pasien yang dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya memuat juga dokumentasi selama proses rujukan

BAB XVII

LAYANAN *TELEMEDICINE*, *HOME VISIT*, DAN *HOME CARE*

Layanan *telemedicine*, *home visit* dan *home care* dilaksanakan berdasarkan permintaan pasien yang masuk ke humas marketing atau call center rumah sakit. Layanan *telemedicine* merupakan layanan telekonsultasi klinis yaitu pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan/ saran tatalaksana. Layanan ini dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video.

Home Visit (Kunjungan Rumah) dilakukan oleh dokter umum dan perawat kepada pasien yang meminta kunjungan ke tempat tinggal pasien untuk dilakukan konsultasi, pemeriksaan fisik dan tatalaksana sesuai kompetensi dokter umum. *Home Care* (Layanan Rumah) dilakukan oleh perawat dan/atau tenaga medis lain untuk melakukan layanan sesuai kompetensi perawat setelah pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit (*post rawat inap*). Prinsip pelayanan *Home Visit* dan *Home Care* adalah pelayanan yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dan berdasarkan permintaan pasien.

Ruang lingkup pelayanan meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, tatalaksana medis dari dokter umum sesuai kompetensi, rawat luka, edukasi kesehatan, dan pengantaran obat. Sasaran dari layanan ini adalah pasien *post rawat inap*, rawat jalan penyakit kronis, pasien dari Perusahaan yang telah melakukan perjanjian kerja sama, dan pasien umum atas permintaan sendiri.

Rumah Sakit menetapkan sumber daya manusia dalam pelayanan *telemedicine*, menetapkan standar prosedur operasional pelayanan *Telemedicine*, serta menyiapkan sarana prasana yang dibutuhkan untuk menunjang layanan. Direktur RS menetapkan besaran biaya layanan. Biaya layanan tersebut dibebankan kepada pasien peminta konsultasi

Prosedur pelayanan tersebut akan dijelaskan pada bab ini. Humas marketing akan melakukan konfirmasi ke pendaftaran. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan dokter dan/atau tim *home visit* dan *home care* terkait penjadwalan. Setelahnya, pasien diminta untuk menyelesaikan pembayaran secara transfer. Pasien wajib mengirimkan bukti pembayaran ke humas marketing.

Untuk layanan *telemedine*, setelah pasien menyelesaikan pembayaran, dilakukan penjadwalan dan koordinasi dengan dokter umum. Dilakukan konsultasi daring via zoom meeting. Dokter umum akan menjelaskan hasil konsultasi dan dapat memberikan resep pada pasien jika dibutuhkan. Pasien diminta untuk melakukan pembayaran obat secara transfer dan obat akan dikirimkan oleh PRIMANTARA.

Untuk layanan *homevisit*, setelah pasien menyelesaikan pembayaran. Tim *Home Visit* (meliputi dokter dan perawat) akan menuju ke tempat tinggal pasien dan melakukan layanan sesuai kebutuhan pasien. Dokter dapat memberikan resep pada pasien jika dibutuhkan. Pasien diminta untuk melakukan pembayaran obat secara transfer dan obat akan dikirimkan oleh PRIMANTARA.

Sedangkan untuk layanan *homecare*, setelah pasien menyelesaikan pembayaran. Tim *Home Care* (meliputi perawat atau petugas laboratorium) akan menuju ke tempat tinggal pasien dan melakukan layanan sesuai kebutuhan pasien. Dokter dapat memberikan resep pada pasien jika dibutuhkan. Pasien diminta untuk melakukan pembayaran obat secara transfer dan obat akan dikirimkan oleh PRIMANTARA. Layanan yang dapat dilakukan pada *homecare* adalah rawat luka, pemasangan kateter, perawatan bayi, baru lahir dan ibu *post partum*, serta pemeriksaan laboratorium tertentu.

Semua pelayanan yang diberikan pada pasien wajib didokumentasikan di rekam medis pasien dan dijaga kerahasiaannya. Setelah layanan selesai, pasien dihibau untuk mengisi survey kepuasan pasien.

Ruang lingkup pelayanan ini meliputi Pemeriksaan fisik, Tatalaksana medis dari dokter umum, Rawat luka, Edukasi kesehatan, Telemedicine / Konsultasi daring, dan Pengantaran Obat. Sasaran dari layanan ini adalah pasien post rawat inap, pasien rawat jalan dengan penyakit kronis, pasien dari perusahaan yang telah melakukan perjanjian kerja sama, pasien umum dengan kondisi tertentu yang menghendaki layanan di rumah. Batasan Kegiatan yang tidak boleh di lakukan:

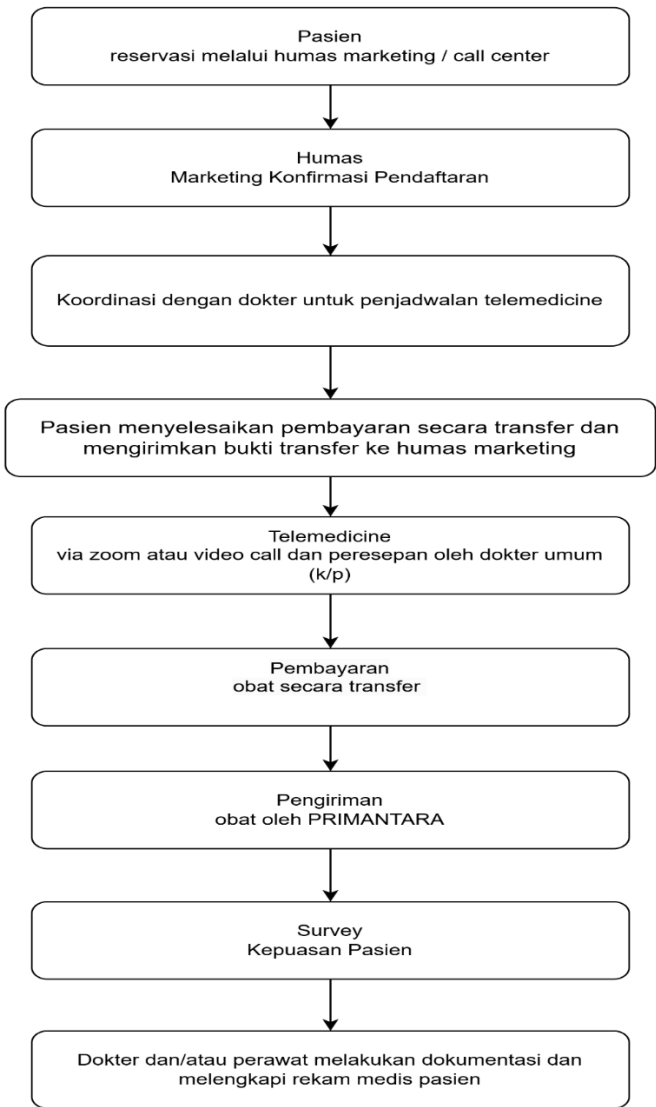
- a. Memberi saran/ obat tanpa sepengetahuan dokter
- b. Memberikan tindakan yang diluar kewenangan tanpa konsultasi dokter
- c. Menerima tips
- d. Memasang infus

Kendaraan yang digunakan untuk layanan home care dan home visit adalah mobil operasional dari Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan Batasan wilayah kunjungan yaitu dapat menjangkau seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Malang. Jadwal pelayanan home care dan home visit adalah Hari Senin-Sabtu pukul 08.00-16.00 (khusus telemedicine dapat dilakukan setiap hari Senin-Minggu sesuai perjanjian dan konfirmasi dengan dokter umum). Standar waktu layanan adalah kondisional sesuai kebutuhan pasien, minimal 15 menit.

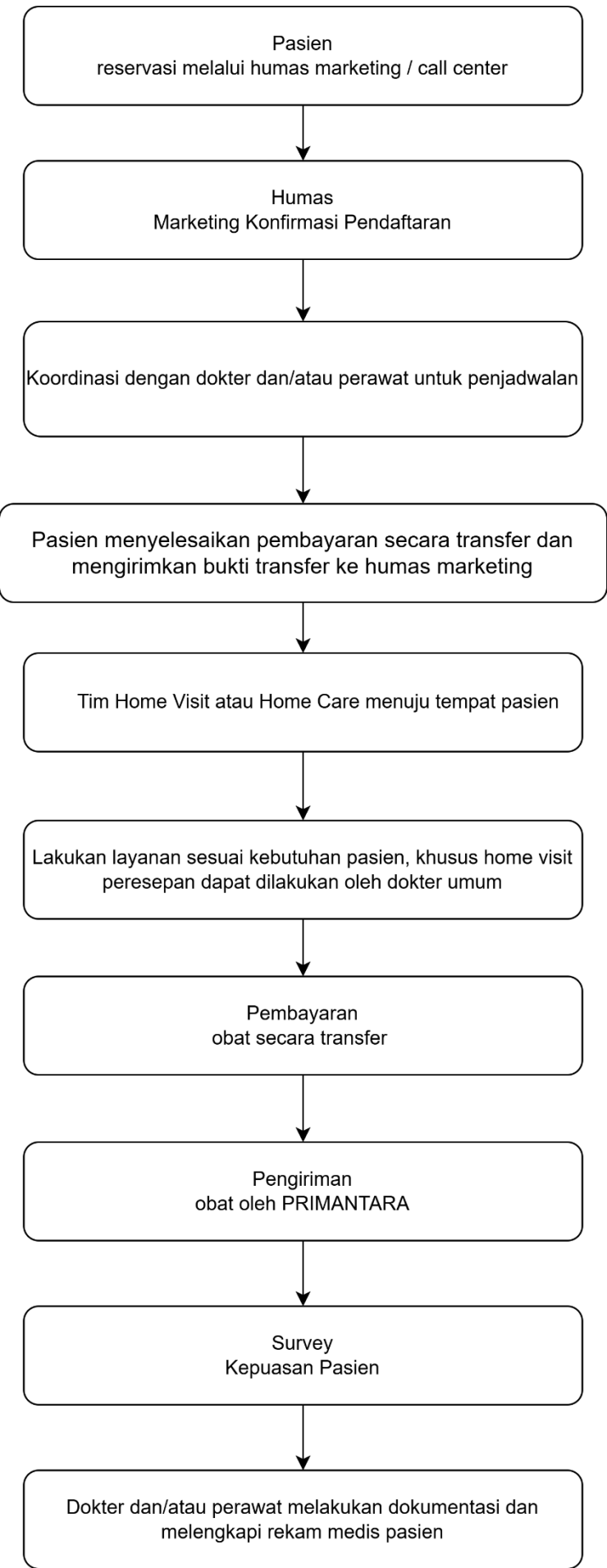
Peralatan yang dibutuhkan untuk pelayanan Home Care dan Home Visit:

- 1. Tensimeter
- 2. Thermogun
- 3. Stetoscope
- 4. Oximeter
- 5. Hands Scoon dan Hansinitizer
- 6. Buku catatan
- 7. Kertas resep
- 8. Leaflet terkait
- 9. ATK
- 10. Set rawat luka (k/p)
- 11. Set sampling darah (k/p)

Bagan 1. Alur Pelayanan Telemedicine



Bagan 2. Alur Pelayanan Home Care / Home Visit



BAB XVIII PENUTUP

Untuk dapat memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, maka rumah sakit memerlukan regulasi yang adekuat tentang pedoman pelayanan dan asuhan pasien, dan panduan ini merupakan acuan utama bagi rumah sakit. Diperlukan pengaturan yang spesifik untuk setiap rumah sakit karena keunikan budaya, situasi dan kondisi setiap rumah sakit, termasuk juga keunikan budaya tenaga medis. Regulasi harus mencerminkan pengelolaan risiko klinis dan pelayanan berfokus kepada pasien (patient centered care). Regulasi tersebut diatas agar dapat diterapkan professional pemberi asuhan, sehingga terwujud asuhan pasien kontinu dan berkesinambungan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 12 Agustus 2024

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular logo. The logo contains a heart shape and the text 'RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA' in blue capital letters.

dr. Nur Mazidah